



GUÍA PARA LA ATENCIÓN, EL MANEJO Y EL CUIDADO

DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO INVASIVO

CALI - COLOMBIA

**GUÍA PARA LA ATENCIÓN, EL MANEJO Y EL CUIDADO
DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE
CUELLO UTERINO INVASIVO**

Cali - Colombia

AVISO

Se debe valorar la pertinencia de los conocimientos científicos publicados en cualquier libro sobre salud y práctica clínica. Quien use esta obra debe consultar diferentes fuentes de información para tener la seguridad de que sus decisiones contengan actualizaciones sobre cambios en procedimientos, indicaciones y contraindicaciones, o inclusión de nuevas tecnologías. Por tanto, es el lector (no los autores ni el editor) el responsable del uso de la información aquí publicada y de los resultados que obtenga de ella.

**GUÍA PARA LA ATENCIÓN,
EL MANEJO Y EL CUIDADO DE
PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
DE CÁNCER DE MAMA
Cali - Colombia**

Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca

Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali

Centro Médico Imbanaco

Clínica de Occidente

Fundación Valle del Lili

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E

Con el apoyo y asesoría de:

City Cancer Challenge Foundation
American Society of Clinical Oncology (ASCO)

**COMITÉ EJECUTIVO CITY
CANCER CHALLENGE - 2019**

*Harold Mauricio Casas Cruz
Subdirector Enfermedades No
Transmisibles – Ministerio de Salud
y Protección Social*

*Carolina Wiesner
Directora – Instituto Nacional
de Cancerología*

*Maria Cristina Lesmes Duque
Secretaria Departamental de Salud –
Gobernación del Valle del Cauca*

*Nelson Sinisterra
Secretario de Salud Pública Municipal –
Alcaldía de Santiago de Cali*

*Jorge Madriñán
Subdirector Médico – Fundación
Valle del Lili*

*Alejandro De la Torre
Director Científico – Centro Médico
Imbanaco*

*Irne Tórres
Gerente General – Hospital Universitario
del Valle “Evaristo García” E.S.E.*

*Maria Liliana Orozco
Directora Calidad – Clínica de Occidente*

*Diana Carolina Robayo
Gerente – Unicáncer*

*Jesús Hernández
Decano Facultad de Salud – Universidad
del Valle*

*Luis Eduardo Bravo
Director Registro Poblacional de Cáncer
de Cali – Universidad del Valle*

*Oscar Ramírez
Director Científico – Fundación Pohema
Fabián Cardona
Vicepresidente de Salud – Acemi*

*Haiberth Giovanni Muñoz
Coordinador Cáncer – Servicio Occidental
de Salud*

*Juan Carlos Mera
Gerente Salud – Emssanar*

*Zoila Palacios
Representante Asociación de Usuarios
Funcáncer*

AUTORES

*Liliana María Yepes.
Ginecóloga Oncóloga.*

*Javier Burbano
Ginecólogo Oncólogo*

*Ángela Zambrano.
Oncóloga Clínica.*

*Iván Ríos Hernández.
Oncólogo Radioterápico.*

*Elsa Cuervo Madrid.
Oncóloga Radioterápica.*

*José Tobías Fuentes.
Oncólogo Radioterápico.*

*María Mercedes Fajardo.
Anestesióloga, Esp en Dolor y Cuidado
Paliativo.*

*María Ximena Varela.
Patóloga.*

*María Claudia Moreno
Patóloga.*

Apoyo metodológico:

*Oscar Ramírez
Pediatra Oncohematólogo*

Asesor metodológico:

*Francisco Escobar Aguilón
Médico, candidato a Magíster en Salud
Pública*

Compilación:

*Juan Camilo Falla
Médico General / Investigador clínico en
medicina translacional*

COLABORADORES ESPECIALES

*Daniel Echeverri
Director de Salud, MD, MSc Epidemiólogo
ProPacífico*

*Julieth Andrea López Arias
Consultor Senior C/Can, Medico Magister
en Derecho Medico
ProPacífico*

*Johan Sebastián Loaiza
Consultor Proyecto de Salud
ProPacífico*

*Carmen del Rosario Palta
Consultor Cáncer – Proyecto de Salud
ProPacífico*

*Jairo Celis
Representante EAPB Comfenalco Valle*

*Ximena Piedrahita
Representante EAPB Comfenalco Valle*

*Jhon Bolaños
Representante EAPB Coomeva*

*Margarita Castro
Representante EAPB Coomeva*

*Leidy Delgado
Representante EAPB Emssanar*

*Ileana de la Espriella
Representante EAPB Servicio Occidental
de Salud*

*Haiberth Giovanni Muñoz
Experto en gestión de riesgo en cáncer*

GLOSARIO

BT: Braquiterapia.

QT: Quimioterapia.

RT: Radioterapia.

CP: Cuidados Paliativos.

TAC: Tomografía Axial Computarizada.

RM: Resonancia Magnética.

PET/CT: Tomografía por Emisión de Positrones.

C/CAN: City Cancer Challenge.

C/CAN: City Cancer Challenge meta de reducción de la mortalidad para el 2025.

CCU: Cáncer de Cuello Uterino.

CCU-I: Cáncer de Cuello Uterino Invasivo.

GMMCC: Grupo Multidisciplinario para el Manejo del Cáncer de Cali.

G-ONC: Ginecología Oncológica.

GPC: Guía de Práctica Clínica.

SG: Sobrevida Global.

Para fines de esta guía, se entiende como Cáncer de Cuello Uterino (CCU) a cualquier fase de la evolución de esta enfermedad, incluyendo el Carcinoma In Situ, también conocido como Neoplasia Intraepitelial de Grado III (NIC III) y todas las fases de enfermedad invasiva (CCU-I), incluyendo la invasión local, regional y a distancia.

AGRADECIMIENTOS

La presente ***guía para la atención, el manejo y el cuidado de pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino invasivo*** fue posible gracias a la cooperación técnica y el apoyo de la asociación de City Cancer Challenge Foundation (C/Can).

Acerca de City Cancer Challenge (C / Can)

C/Can apoya a ciudades de todo el mundo en su labor para mejorar el acceso a una atención oncológica equitativa y de calidad. Desde su lanzamiento en 2017 por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), C/Can ha desarrollado un nuevo modelo para abordar el acceso a la atención del cáncer que, por primera vez, posiciona a la ciudad como un facilitador clave en la respuesta de los sistemas de salud hacia el cáncer. Más información (<https://citycancerchallenge.org>).

Agradecemos todo el apoyo y la contribución de los expertos temáticos durante el desarrollo de la presente guía, por su activa participación y constante compromiso en las reuniones de socialización y debate, así como su interés en llevar a feliz término este proyecto de ciudad.

Así mismo, agradecemos el apoyo institucional entre City Cancer Challenge y ProPacífico por forjar y mantener este acuerdo colaborativo que ha permitido llevar a feliz término el desarrollo de la presente guía. Y de manera especial a:

Maria Isabel Ulloa
Directora Ejecutiva
ProPacífico

María Fernanda Navarro
Directora Latinoamérica
City Cancer Challenge



INTRODUCCIÓN

En enero de 2017, la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC) lanzó la iniciativa llamada “City Cancer Challenge: Desafío de Ciudades Contra el Cáncer (C/Can)”. Esta iniciativa nació como una respuesta al objetivo global de reducir la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles por lo menos en un 25% para el año 2025 (1), siendo el programa insignia específico para el cáncer. UICC parte del hecho de que a pesar de que las intervenciones de prevención primaria son importantes para la reducción de la incidencia y mortalidad, la prevención secundaria y terciaria deben también fortalecerse, con el fin de brindar un tratamiento oportuno y eficaz, disminuyendo la mortalidad atribuible al cáncer (2,3).

Santiago de Cali, es la primera ciudad en el mundo en implementar esta iniciativa (4). Está ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, el cual tiene una población total de 4,660,741 de personas para el año 2016, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta ciudad es considerada, la tercera más poblada de Colombia, con una población estimada para el año 2016, que corresponde a 2,394,925 habitantes, con un 47.8% (1,144,848) de población mas-

culina y un 52.2% (1,250,077) de población femenina.

El Observatorio Global de Cáncer (GLOBOCAN), es una entidad que hace parte de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) que es un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (5). Periódicamente GLOBOCAN publica información sobre el estado de la epidemiología del cáncer a nivel mundial. Para el año 2018, según GLOBOCAN, el CCU fue la novena causa de cáncer a nivel mundial, sin contar los tumores cutáneos diferentes a melanoma, y la cuarta causa entre las mujeres, con un total de 569,847 casos diagnosticados, correspondiendo a un 3.2% de todos los tumores a nivel mundial y provocando un total de 311,365 muertes, correspondiendo al 3.3% de todas las muertes por cáncer (6).

Alrededor del 85% de la carga mundial que genera la enfermedad se produce en las regiones de bajos y medianos ingresos. Los países que presentan un alto riesgo de padecer esta enfermedad, es decir, que tienen las tasas estandarizadas por edad más altas, se encuentran principalmente ubicados en África y Suramérica (6).

En Colombia, para el quinquenio 2007-2011, se estimó una tasa de incidencia de CCU de 18.7 por 100,000 habitantes, constituyéndose como la segunda causa de cáncer más frecuente entre la población femenina después del cáncer de mama (7). Para el 2018, GLOBOCAN reporta que el CCU es la cuarta causa de cáncer en mujeres en Colombia, muy posiblemente secundario al mejoramiento de las estrategias de prevención y al aumento de la incidencia de cáncer de colon, que ahora se ubica en la segunda posición para este grupo poblacional (6). Para el 2016 el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia (INC), publicó en su anuario estadístico que, durante el año mencionado, hicieron diagnóstico de 491 casos de CCU, correspondiendo al 7.1% de todos los tumores diagnosticados en su centro y 12.2% de todos los tumores diagnosticados en mujeres (8).

Se han identificado diferentes factores de riesgo que subyacen al desarrollo de CCU (9,10). La infección por Virus del Papiloma Humano (VPH) se considera como un factor necesario, más no suficiente, para el desarrollo de CCU (11). Aproximadamente 15 serotipos de VPH son considerados de alto riesgo para CCU, de estos, los serotipos 16 y 18 se registran como causales

en aproximadamente el 71% de los casos, mientras que los serotipos 31, 33, 45, 52 y 58 corresponden a un 19% de los casos (12).

El proceso biológico que inicia con la infección y termina en el cáncer invasivo, y las probabilidades de regresión o persistencia han sido descritos previamente (13). Las lesiones pre-invasivas tienen diferentes grados de regresión y de progresión a carcinoma invasivo, así, las neoplasias intraepiteliales de grado I (NIC I), tienen un porcentaje de regresión del 60%, de progresión a carcinoma in situ (NIC III) del 30%, y a carcinoma invasivo del 1%. Las neoplasias intraepiteliales de grado II (NIC II), tienen una regresión del 40% y una progresión a CIN III del 20%, con un riesgo del 5% de desarrollar cáncer invasivo¹⁴. La NIC III tiene un porcentaje de regresión del 33% y un riesgo mayor al 12% de desarrollar cáncer invasivo (14,15).

Lo anterior ha permitido establecer recomendaciones sobre la realización de pruebas de detección del virus y el tratamiento de las lesiones precancerosas de acuerdo con el grupo etario, considerándose como estrategias de prevención primaria y secundaria con alto impacto sobre la incidencia y mortalidad de esta neoplasia (16,17).

En relación con la tamización, Colombia ha avanzado en la introducción de pruebas alternativas a la citología que incrementan la sensibilidad y reducen los problemas de control de calidad (pruebas de DNA-VPH) (18), y métodos que permiten abordajes programáticos en los que se tamiza y se trata a una mujer en una única visita (técnicas de inspección visual), con el fin de asegurar un tratamiento eficaz en mujeres pertenecientes a poblaciones ubicadas en regiones con difícil acceso a los servicios de salud (19–21).

El Instituto Nacional de Cancerología (INC), en El Plan Nacional para el Control del Cáncer (PNCC) ha establecido como meta la reducción de la tasa de mortalidad a una frecuencia inferior al 5 por 100.000 para el año 2021. En Colombia, desde el 2012, se ha ideado una de las estrategias más importantes, consistente en la aprobación e inclusión dentro del plan ampliado de inmunizaciones (PAI), de la vacuna tetravalente contra el HPV para niñas desde cuarto a undécimo grado escolar, con edades entre 9 y 18 años, en Colombia desde el año 2012. Es importante tener claro que la utilización de esta vacuna se encuentra aprobada a nivel mundial para mujeres hasta los 45 años, y en hombres desde los 9 a los 25 años (22–24).

El modelo de control del cáncer, descrito en el PNCC, se enfoca en la detección temprana, el tratamiento y rehabilitación y el cuidado paliativo, haciendo énfasis en la necesidad de promover una atención continua, desde las acciones de prevención hasta las de rehabilitación y cuidado paliativo. Esta guía pretende hacer énfasis en el diagnóstico y tratamiento, rehabilitación, cuidado paliativo y cuidado de enfermería en pacientes con CCUI.

Una característica importante con respecto al C/Can, y a su vez, una decisión unánime del GMMCC, resulta en la obligación de brindar el mejor manejo posible a las pacientes con cáncer de cuello uterino, pues es de esta forma cómo se logrará tener un impacto significativo en la mortalidad.

ALCANCE DE LA GUÍA

En el mismo sentido del PNCC, la guía pretende brindar los lineamientos generales estandarizados, que deben seguir los miembros de los equipos multidisciplinarios de los servicios oncológicos de la ciudad, para contribuir en la reducción de la mortalidad prevenible por esta patología y mejorar la calidad de vida de los pacien-

tes. Además, implementar un flujo de tratamiento efectivo que permita disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer. Esta guía no comprende aspectos de tipo socioeconómico ni tampoco análisis de costos de las diferentes estrategias de manejo e intervenciones terapéuticas propuestas.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la calidad y efectividad en la atención de los pacientes con cáncer de cuello uterino de la ciudad de Cali, aumentando así la probabilidad de sobrevivir a cinco años de este grupo poblacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Asegurar un adecuado, oportuno y efectivo tratamiento para las distintas fases del CCU, previniendo la morbilidad y mortalidad por esta patología.
- Concientizar y educar al paciente y acudiente sobre la enfermedad, el manejo y su papel en el tratamiento.

Población diana de la guía: mujeres con diagnóstico de CCU.

Población a quien se dirige la guía y aspectos clínicos: esta guía está dirigida a todos los proveedores de salud que intervienen en el manejo de mujeres con CCU tales como: oncólogos clínicos, cirujanos, gineco-oncólogos, oncólogos radioterápicos, ginecólogos generales, médicos generales, profesionales de cuidado paliativo, profesionales de enfermería, radiólogos, médicos nucleares, patólogos y personal de gestión administrativa.

Esta guía no incluye el manejo de tumores de cérvix con características histológicas poco frecuentes como el carcinoma neuroendocrino, sarcoma de cérvix, entre otros.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda sistemática de las guías de práctica clínica (GPC) basadas en la evidencia utilizando las recomendaciones de la guía metodológica para la adopción/adaptación de guías de práctica clínica del Ministerio de salud y Protección Social de septiembre de 2017. La búsqueda se llevó a cabo en los buscadores de los organismos compiladores y desarrolladores de GPC. Los criterios de selección fueron: guías publicadas desde el 2016, en inglés o en español y que comprendieran la fase de tratamiento del cáncer de cuello uterino invasor. También se incluyó la GPC del Ministerio de salud y Protección social del 2015. Se tuvieron en cuenta también las recomendaciones de las principales sociedades científicas (NCCN, FIGO, SEGO, SEOM, ESGO y ESMO). Los organismos compiladores consultados fueron: Guidelines International Network (<http://www.g-i-n.net>), Agency for Healthcare Research and Quality/National Guidelines Clearinghouse (<http://www.guideline.gov>), CMA infobase: Clinical practice Guidelines (<http://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx>) y Fisterra Guías Clínicas (<http://www.fisterra.com/guias-clinicas/>).

Los organismos desarrolladores consultados fueron: National Institute for Clinical Excellence (NICE), Scottish Intercollegiate

Network, American College of Physicians, Health Services/Technology Assessment Texts (HSTAT), OPS, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENEC-TEC), Agency for Healthcare Research and Quality, Consejo Nacional Australiano de Salud e Investigación Médica: guías para la práctica clínica. Además, se realizó la búsqueda sistemática de GPC en PubMed, Trip database, Google Académico y Scielo.

En esta búsqueda se encontraron 6 guías en NICE, 6894 en GIN, 1 en CENETEC, 108 en Trip database, 130 en PubMed y 947 en Google Académico. Los términos MeSH utilizados fueron: Practice "Guidelines" AND "Uterine Cervical Neoplasms", "Guidelines" AND "cervix uteri" y "cervical cancer". De los resultados de esta búsqueda 7 guías cumplieron los criterios de selección para la revisión. Posteriormente, a estas guías identificadas se les realizó un proceso de tamización secundaria para definir el paso a la etapa de evaluación de calidad metodológica AGREE II por dos evaluadores.

Se les realizó la evaluación AGREE II a 7 guías y los puntajes son los siguientes:

Tabla 1 Puntaje AGREE II de las GPC seleccionadas

	Dominio 1 Alcance y objetivo	Dominio 2 Participación de los implicados o grupos de interés	Dominio 3 Rigor en la elaboración	Dominio 4 Claridad de presentación	Dominio 5 Aplicabilidad	Dominio 6 Independencia editorial
ASCO Invasive CerCa 2016 ²⁷	100%	72%	50%	100%	83%	92%
ESGO ESTRO ESP 2018 ²⁹	100%	94%	90%	100%	63%	100%
ESMO 2017 ²⁶	97%	61%	65%	97%	8%	92%
MEXICO 2010	92%	69%	77%	94%	19%	92%
JSGO 2017	100%	100%	85%	100%	17%	100%
KSGO 2017 ²⁵	100%	72%	81%	94%	13%	100%
NCCN 2020 ²⁸	86%	83%	82%	97%	73%	100%

*NOTA: se genera una semaforización para fines de visualización:
Verde es ≥ 60%, Amarillo es 60%-50%, Rojo es <50%*

Estas guías fueron revisadas por los expertos temáticos para la realización del consenso. La GPC del Ministerio no fue sometida a la evaluación del AGREE II dado que fue incluida como insumo primario en esta revisión.

En Colombia, la atención del cáncer se centra en servicios de mediana y alta compleji-

dad, con el fin de acceder a un manejo multidisciplinario; sin embargo, sigue siendo una limitante el acceso para pacientes que llegan de áreas rurales. Esta guía intentará abordar la problemática con las instancias gubernamentales y no gubernamentales que participan en el manejo.

TABLA DE CONTENIDO

AUTORES	6
GLOSARIO	7
INTRODUCCIÓN.	9
ALCANCE DE LA GUÍA.	12
OBJETIVOS	12
OBJETIVO GENERAL:	12
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	12
METODOLOGÍA.	13
TABLA DE CONTENIDO	15
1. RECOMENDACIONES	17
¿Cuáles son las recomendaciones para realizar un diagnóstico de cáncer cervicouterino?	17
¿Cuáles son las recomendaciones relacionadas con el proceso de estratificación del cáncer cervicouterino?	17
¿Cuáles son las recomendaciones para clasificar histopatológicamente el cáncer cervicouterino?	18
¿Cuáles con las recomendaciones para el manejo del Cáncer Cervicouterino en estadios tempranos?	18
¿Cuáles con las recomendaciones para el manejo del Cáncer Cervicouterino en estadios avanzados?	20
En términos generales, ¿qué recomendaciones deben seguirse en relación con la quimioterapia?	21
En términos generales, ¿qué recomendaciones deben seguirse en relación con la radioterapia?	21
¿Cuáles son las recomendaciones para el seguimiento de pacientes con cáncer cervicouterino?	22
2. ASPECTOS CLÍNICOS	22
2.1. ESTADIFICACIÓN DEL CCU	22
2.2. FACTORES PRONÓSTICOS:	26
2.3. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA:	26
2.4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS DIFERENTES ESTADIOS	28
2.5. TRATAMIENTO DEL CCU:	30
2.5.1. Especificaciones sobre la quimioterapia	34
2.5.2. Especificaciones sobre la radioterapia:	35
2.6. SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES QUE HAN FINALIZADO EL TRATAMIENTO PARA CCU	36
3. CUIDADO PALIATIVO	37
3.1. Objetivos	37
4. ENFERMERÍA ONCOLÓGICA	43
Rol clínico:	43
Rol en cuidado paliativo:	44
Rol educativo:	44
Rol administrativo:	44
Rol integrativo:	44

5. REVISIÓN DE EVALUACIONES ECONÓMICAS	46
5.1. COSTO-EFECTIVIDAD DEL PET-TC	47
Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali	48
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	49
6.1. ASPECTOS GENERALES	49
6.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES	51
6.3. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS	52
6.4. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS O FACILITADORES PARA RESOLVER LAS BARRERAS	54
6.4.1. Equipo de salud multidisciplinario	54
6.4.2. Gestión del riesgo en cáncer	55
6.4.3. Mecanismos de pago	55
6.4.4. Monitoreo y seguimiento	56
6.4.5. Paciente, familia y comunidad	56
6.4.6. Plataformas de información	56
6.4.7. Redes integrales e integradas en salud	56
6.4.8. Unidad de práctica integrada en cáncer	57
7. PLAN DE ACTUALIZACIÓN	58
ANEXOS	59
ANEXO 01. CONFLICTO DE INTERESES	59
ANEXO 02. AGREE II	62
ANEXO 03. REVISIÓN DE PARES EXTERNOS	70
ANEXO 04. CONSENSO DE EXPERTOS	74
REFERENCIAS	78

1. RECOMENDACIONES

¿Cuáles son las recomendaciones para realizar un diagnóstico de cáncer cervicouterino?

N	RECOMENDACIÓN
1	En caso de no observar lesiones macroscópicas en el cérvix con un reporte de pruebas de tamización alterado, se recomienda realizar colposcopia más biopsia para la realización de un diagnóstico claro a nivel histopatológico.
2	La evaluación de la enfermedad extrauterina debe incluir siempre evaluación del espécimen a través de biopsia con aguja tru-cut para confirmación o por medio del PET/CT.

¿Cuáles son las recomendaciones relacionadas con el proceso de estratificación del cáncer cervicouterino?

N	RECOMENDACIÓN
3	Se recomienda utilizar la estadificación clínica y radiológica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), publicada en enero de 2019 (pero correspondiente al consenso de 2018).
4	Se recomienda realizar la estadificación principalmente de forma clínica, con los hallazgos encontrados durante el examen físico, en conjunto con técnicas imagenológicas como la resonancia magnética (RM), ya que permiten un adecuado estudio de la extensión y el grado de compromiso local a nivel de los parametrios, la vagina, el cuerpo del útero y el recto.
5	Se recomienda la realización de tomografía computarizada (TAC) para el estudio del compromiso de ganglios linfáticos.
6	Se sugiere la realización de PET/CT para el estudio del compromiso tisular a distancia. Del mismo modo, es el método de elección para la planeación del tratamiento radioterápico con intención curativa. Se puede realizar TAC o RMN en caso de no contar con PET.
7	Se recomienda realizar cistoscopia o rectosigmoidoscopia cuando existe sospecha de compromiso vesical o rectal, según los hallazgos en la exploración física y en la RMN.
8	Se sugiere realizar una radiografía de tórax, y ecografía renal si hay sospecha de hidronefrosis, como complemento al TAC o RM, para determinar presencia de enfermedad a distancia.

¿Cuáles son las recomendaciones para clasificar histopatológicamente el cáncer cervicouterino?

N	RECOMENDACIÓN
9	Se recomienda utilizar la clasificación histopatológica de la OMS para el CCU.
10	El espécimen para analizar debe contener estroma de soporte (no fragmentado) que permita confirmar la presencia o ausencia de invasión

¿Cuáles con las recomendaciones para el manejo del Cáncer Cervicouterino en estadios tempranos?

BLOQUE TEMÁTICO	N	RECOMENDACIÓN
Tto: Estadio IA1	11	Se recomienda el manejo quirúrgico a toda mujer con diagnóstico de Ca cervicouterino en estadio IA1. Sin embargo, en situaciones especiales, se puede utilizar radioterapia como tratamiento definitivo.
Tto: Estadio IA1	12	Se recomienda definir la decisión de la técnica quirúrgica (entre traquelectomía, conización o histerectomía) dependiendo del deseo de fertilidad, mas lifadenectomía si hay invasión del espacio linfovascular (LVSI).
Tto: Estadio IA1	13	En mujeres con el deseo de preservar la fertilidad, la conización o la traquelectomía simple son técnicas aceptadas con buena evidencia en los casos en los que no hay invasión linfovascular, si bien la invasion linfovascular per se no contraindica la realizacion de conizacion o traquelectomia radical.
Tto: Estadio IA1	14	En casos donde hay invasión linfovascular, se recomineda realizar evaluación de los nodos linfáticos regionales de acuerdo con la disponibilidad de tecnología y personal capacitado, proponiendo una diseccion de nodos linfáticos pélvicos (PLND), o uso de ganglio centinela.
Tto: Estadio IA1	15	Se sugiere repetir conización ante márgenes positivos, antes de considerarse una enfermedad más avanzada.
Tto: Estadio IA1	16	En mujeres que no tienen deseo de fertilidad, o en mujeres que no se encuentran en edad fértil, se sugiere como opción la realización de histerectomía extrafascial.
Tto: Estadio IA1	17	En aquellos casos en que la paciente no sea candidata a un manejo quirúrgico debido a enfermedades asociadas, se sugiere braquiterapia como alternativa de manejo.
Tto: Estadio IA2	18	Si la paciente no tiene deseo de fertilidad, se recomienda realizar histerectomía radical modificada + PLND bilateral + muestreo de ganglios para-aórticos (si es posible), o ganglio centinela donde sea posible según la disponibilidad de tecnología y personal capacitado.
Tto: Estadio IA2	19	Se sugiere como alternativa de manejo la utilización de radioterapia pélvica + braquiterapia.

Tto: Estadio IA2	20	En caso de que se desee preservar la fertilidad, también se puede realizar traquelectomía radical + PLND + muestreo de ganglios para-aórticos (si es posible).
Tto: Estadio IA2	21	No se recomienda realizar histerectomía luego de tratamiento conservador.
Tto: Estadio IB1	22	Se debe considerar riesgo bajo cuando la extensión tumoral máxima es menor a 2 cm, cuando la invasión del estroma cervical es menor al 50% y cuando no hay presencia de ganglios linfáticos sospechosos de compromiso en las imágenes realizadas.
Tto: Estadio IB1	23	Para tumores de bajo riesgo estadio IB1, se sugiere la realización de histerectomía radical modificada + PLND, o de histerectomía radical modificada (HRM) + RT adyuvante, o HRM + RT pélvica + quimioterapia en dosis bajas.
Tto: Estadio IB1	24	Se sugiere como alternativa de manejo la utilización de radioterapia + braquiterapia + dosis baja de quimioterapia basada en platinos.
Tto: Estadio IB1	25	Se recomienda la radioterapia y quimioterapia como terapia adyuvante en los casos en que haya compromiso ganglionar, parametrial o de márgenes positivos.
Tto: Estadio IB1	26	En mujeres jóvenes que desean preservar la fertilidad, se puede realizar una traquelectomía radical. La traquelectomía se puede realizar por vía abierta abdominal, laparoscópica o vaginal.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	27	Se sugiere ofrecer cirugía o radioterapia, ya que ofrecen resultados similares en cuanto al pronóstico oncológico, y cada uno de los tipos de manejo se elegirán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y a las necesidades propias de la paciente.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	28	Se recomienda que la cirugía radical sea realizada por ginecólogo-oncólogo.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	29	Si se detecta compromiso ganglionar, presencia de márgenes positivos o compromiso de parametrios, se recomienda tratamiento adyuvante con radioterapia + quimioterapia concomitante.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	30	En detección inequívoca de compromiso ganglionar por biopsia o PET-CT, se recomienda como tratamiento de elección quimioterapia + radioterapia + braquiterapia.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	31	Si los ganglios centinela no son detectados, se debe realizar linfadenectomía sistemática del lado en el cual no se encuentre el ganglio centinela, o bilateral si es necesario.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	32	Se sugiere no ofrecer quimioterapia neoadyuvante (CTNA) seguida de cirugía. No obstante, en caso de que lo considere el médico tratante, se puede llevar caso a Junta Multidisciplinaria para evaluar el caso y definir conducta a seguir.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	33	Se sugiere realizar teleterapia + braquiterapia y quimioterapia con platinos a dosis bajas en pacientes con Ca cervicouterino estadio IIA2.
Tto: Estadio IB2 y IIA1	34	Se recomienda la RT pélvica + quimioterapia concurrente a bajas dosis basada en platinos + braquiterapia

¿Cuáles con las recomendaciones para el manejo del
Cáncer Cervicouterino en estadios avanzados?

BLOQUE TEMÁTICO	N	RECOMENDACIÓN
Tto: Estadio IIB a IIIA	35	Se recomienda tratamiento radical con RT + quimioterapia concurrente a bajas dosis basada en platinos + braquiterapia.
Tto: Estadio IIB a IIIA	36	En casos de enfermedad residual posterior a la quimio radiación, recaída central o en casos de persistencia de tumores menores de 2 cm sin enfermedad a distancia, se recomienda realizar exenteración pélvica.
Tto: Estadio IIIB a IVA	37	Se recomienda realizar RT pélvica + quimioterapia concurrente en bajas dosis basada en platinos + braquiterapia + cuidados paliativos en pacientes con Ca cervicouterino estadio IIIB o IVA.
Tto: Estadio IIIB a IVA	38	Se recomienda considerar RT de campo extendido cuando se encuentre compromiso ganglionar demostrado a nivel paraaortico.
Tto: Estadio IIIB a IVA	39	En los casos de persistencia de la enfermedad o de recaída, se sugiere utilizar quimioterapia sistémica o incluso cirugía de rescate, siempre y cuando la persistencia sea central y tamaño tumoral menor de 2 cm.
Tto: Estadio IVB	40	Se recomienda ofrecer cuidado paliativo general, incluyendo la utilización de quimioterapia y radioterapia paliativas, en el tratamiento de la enfermedad metastásica.
Tto: Estadio IVB	41	Se recomienda la utilización de quimioterapia con intención paliativa + bevacizumab (como inhibidor de la angiogénesis) + RT paliativa individualizada (tratamiento de síntomas como sangrado vaginal y descargas vaginales) + cuidado paliativo, en pacientes con Ca cervicouterino metastásico.
Tto: Estadio IVB	42	Se sugiere la búsqueda de posibles ensayos clínicos en los que los pacientes pudieran ser incluidos.
Tto: Enfermedad recurrente	43	Se debe tener en cuenta el uso de agentes quimioterápicos como el platino, la radioterapia y la localización de la recurrencia para definir posibilidad elección de tratamiento: o Recurrencia central sin radioterapia previa, lo indicado es QT +RT o QT + RT + BT. • Recurrencia central con RT previa: Se recomienda exenteración. • Recurrencia no central sin RT: Se recomienda QT + RT + BT. • Recurrencia no central previa RT: RT intersticial con o sin QT o QT + Bevacizumab + cuidados paliativos.
Tto: Enfermedad recurrente	44	En caso de segunda recurrencia, se sugiere ingreso a estudio clínico o QT, en conjunto con cuidado paliativo.

En términos generales, ¿qué recomendaciones deben seguirse en relación con la quimioterapia?

N	RECOMENDACIÓN
45	Se recomienda el uso de quimioterapia concurrente a radioterapia, basada en platinos, a dosis bajas para enfermedad avanzada sin metástasis a distancia.
46	Se sugiere para estadios avanzados (metástasis) o de recurrencia con quimioterapia, el uso de una terapia basada en platinos, así podrá administrarse cisplatino + paclitaxel + bevacizumab, o carboplatino + paclitaxel + bevacizumab.
47	Se recomienda realizar quimioterapia que incluya un platino + un taxano.
48	Se recomienda que, en caso de presentarse algún retraso en el acceso a quimioterapia, no se retrase la provisión de radioterapia, en pacientes con Ca cervicouterino en quienes se les ha indicado manejo con QT + RT.

En términos generales, ¿qué recomendaciones deben seguirse en relación con la radioterapia?

N	RECOMENDACIÓN
49	En caso de mujeres premenopáusicas, con deseo de fertilidad, con requerimiento de tratamiento con RT, se recomienda realizar inicialmente una transposición ovárica por parte del servicio de ginecología oncológica, con el fin de disminuir la cantidad de radiación que podrían recibir los ovarios. A este tipo de mujeres se les debe realizar radioterapia de intensidad modulada (IMRT).
50	Se recomienda realizar radioterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer cervicouterino, previa simulación con CT pélvico o abdomino-pélvico, si el caso así lo requiere.
51	Se recomienda administrar dosis totales de la siguiente forma: • Estadios IA1 y IA2: dosis total a punto A 70-80 Gy. • Estadios IB1-IIA1: dosis total a punto A 80-85 Gy. • Estadios IB2-IIA2, IIB, III y IVA: dosis total en el punto A $\geq$ 85 Gy.
52	Se recomienda realizar Radioterapia Adyuvante postoperatoria en aquellas pacientes que hayan sido llevadas a cirugía oncológica y que presenten criterios mayores para adyuvancia (márgenes positivos, ganglios linfáticos comprometidos, parámetros comprometidos) o en caso de cirugía no oncológica con factores de mal pronóstico (tumor grande, invasión estromal o linfo vascular).
53	En caso de no presentar criterios mayores, se recomienda la utilización de los criterios de Sedlis, para definir la necesidad de adyuvancia con RT.
54	Se recomienda realizar braquiterapia guiada por imagen para delimitación de volúmenes objetivo y de órganos sanos mediante la utilización de TAC, o de RM cuando sea posible.

¿Cuáles son las recomendaciones para el seguimiento de pacientes con cáncer cervicouterino?

N	RECOMENDACIÓN
55	Se recomienda hacer consultas de control cada 3 o 4 meses durante los primeros 2 años y luego cada 6 a 12 meses, hasta completar 5 años.
56	Se recomienda realizar imágenes de TAC o RMN en pacientes con sospecha clínica de recaída local o sospecha de metástasis, y PET CT según hallazgos.
57	Se recomienda la utilización de imágenes y laboratorios de acuerdo con los síntomas y hallazgos clínicos evidenciados en las valoraciones de seguimiento.
58	Se sugiere realizar PET/CT en aquellas pacientes en quienes se les ha realizado tratamiento completo radical, con estadio FIGO IB2 o superior, para determinar o descartar presencia de enfermedad metastásica. También en pacientes que requerirían RT adyuvante o Quimiorraditerapia concomitante por factores de riesgo (adenopatías positivas, parametrio afectado, márgenes positivos) para descartar metástasis a distancia.

2. ASPECTOS CLÍNICOS

2.1. ESTADIFICACIÓN DEL CCU

Para fines de City Cancer Challenge (C/Can), el GMMCC ha decidido utilizar la estadificación clínica y radiológica de la “Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras” (FIGO), publicada en enero de 2019 (pero correspondiente al consenso de 2018) (25) por encima de la clasificación TNM publicada en las Guías de la NCCN Versión 3 de 2019. Esta clasificación permite un enfoque práctico para el manejo principalmente de tipo quirúrgico por los servicios de Ginecología Oncológica (G-ONC) y permite la generación de un adecuado análisis pronóstico para cada subtipo de CCU. En la Tabla 1 se expone una visión comparativa entre las dos clasificaciones mencionadas.

El CCU, al igual que la mayoría de los tumores sólidos (26), se disemina de forma local a tejidos y órganos adyacentes como lo son el parametrio (27), la vagina, el útero, la vejiga y el recto (28). La diseminación a distancia puede ocurrir también en el CCU, principalmente por diseminación linfática, la cual se origina por el compromiso inicial de ganglios linfáticos regionales como lo son los obturadores, ilíacos externos e internos y su consecuente progresión a la región para-aórtica (29–31). La metástasis a distancia compromete principalmente los pulmones y los huesos, usualmente por diseminación hematógena (32,33).

La estadificación se realiza principalmente de forma clínica, con los hallazgos encontrados durante el examen físico. De acuerdo a la última actualización de FIGO, realizada durante 2018 y publicada en 2019, las imágenes diagnósticas y la histopatología juegan ahora un papel importante en el proceso de estadificación (25), de esta forma, técnicas imagenológicas como la resonancia magnética (RM), permiten un adecuado estudio de la extensión y el grado de compromiso local a nivel de los parámetros, la vagina, el cuerpo del útero y el recto (34,35). La tomografía computarizada (TAC) es ideal para el estudio del compromiso de ganglios linfáticos (36,37), y el PET/CT para el estudio del compromiso tisular a distancia. Así mismo, el PET/CT es el método de elección para la planeación del tratamiento radioterápico con intención curativa (38). La linfadenectomía para-aórtica es también una estrategia útil en la clasificación ganglionar.

Pese a que es posible presentar metástasis a distancia en cualquier estadio FIGO, es improbable en el caso de no existir afectación ganglionar pélvica. No obstante, tiene capital importancia conocer la existencia de metástasis a distancia, ya que en estos casos el tratamiento pasa a ser paliativo y la supervivencia es precaria (39). El valor de la PET/CT con 18F-FDG en el cáncer de cuello uterino se centra en la detección del compromiso ganglionar y de metástasis a distancia. De esta manera, la PET/CT en la estadificación, se describe que cambia el manejo terapéutico entre un 10 y un 32% de los casos en los que los pacientes con cáncer de cuello uterino, debido a la no detección de adenopatías para-aórticas por otras técnicas, también por metástasis a distancia y otros hallazgos adicionales como segundas neoplasias (40). En la Tabla 2 se expone la clasificación revisada de 2018 de FIGO para el CCU-I.

Tabla 1 Clasificación comparativa de FIGO y TNM para el CCU

Categorías TNM	Estadios FIGO	Definición
T - Tumores primarios		
TX		Tumor primario que no puede ser valorador
T0		No evidencia de tumor primario
Tis		Carcinoma in situ (carcinoma pre-invasivo)
T1	I	Tumor confinado al cérvix
T1a	I A	Carcinoma invasivo diagnosticado solamente por microscopía. Invasión estromal con una profundidad máxima de 5,0 mm medida desde la base del epitelio y un horizonte de 7,0 mm o menos
T1a1	I A1	Invasión estroma medida en 3,0 mm o menos en profundidad y 7,0 mm o menos de extensión en el horizonte.
T1a2	I A2	Invasión estromal medida en más de 3,0 mm y no mayor de 5,0 mm con un horizonte de extensión de 7,0 mm o menos.

T1b	I B	Lesión clínicamente visible confinada al cérvix o lesión microscópica mayor que T1a/IA2
T1b1	I B1	Lesión clínicamente visible de 4,0 cm o menos en su mayor dimensión.
T1b2	I B2	Lesión clínicamente visible de más de 4,0 cm en su mayor dimensión.
T2	II	Tumor invade más allá del útero, pero no a la pared pélvica o al tercio inferior de la vagina
T2a	II A	Tumor sin invasión a parametrios
T2a1	II A1	Lesión clínicamente visible de 4,0 cm o menos en su mayor dimensión.
T2a2	II A2	Lesión clínicamente visible de más de 4,0 cm en su mayor dimensión.
T2b	II B	Tumor con invasión a parametrios
T3	III	Tumor involucra tercio inferior de la vagina, o se extiende a la pared pélvica, o causa hidronefrosis o alteración de la función renal
T3a	III A	Tumor compromete tercio inferior de la vagina
T3b	III B	Tumor se extiende a la pared pélvica, o causa hidronefrosis o alteración de la función renal
T4	IV A	Tumor invade la mucosa de la vejiga o recto, o se extiende más allá de la pelvis verdadera.
T - Tumores primarios		
NX		No se puede valorar los ganglios linfáticos regionales
N0		No hay metástasis en ganglios linfáticos regionales
N1		Metástasis de ganglios linfáticos regionales
M - Metástasis distantes		
M0		No hay metástasis a distancia
M1		Metástasis a distancia (incluye linfáticos inguinales y enfermedad intraperitoneal). Excluye metástasis a vagina, serosa pélvica y anexos.

Tabla 2 Clasificación revisada de FIGO 2018 para el CCU

Estadio	Compromiso
Estadio I: el carcinoma está confinado estrictamente al cuello uterino.	
Estadio IA	Invasión a la membrana basal menor a 5 mm de profundidad.
Estadio IA1	Invasión del estroma < 3 mm.
Estadio IA2	Invasión del estroma ≥ 3 mm a < 5 mm.
Estadio IB	Carcinoma invasivo con un compromiso del estroma ≥ 5 mm, limitado al cuello uterino.
Estadio IB1	Invasión del estroma ≥ 5 mm y < 2 cm, con un diámetro tumoral < 2 cm.
Estadio IB2	Invasión del estroma ≥ 2 cm, con un diámetro tumoral < 4 cm.
Estadio IB3	Invasión del estroma con un diámetro tumoral ≥ 4 cm.
Estadio II: el compromiso tumoral compromete más allá del tejido uterino sin alcanzar a comprometer el tercio inferior de la vagina o la pared pélvica.	
Estadio IIA	Compromiso de los dos tercios superiores de la vagina, sin compromiso parametrial.
Estadio IIA1	Invasión del estroma con un diámetro máximo < 4 cm.
Estadio IIA2	Invasión del estroma con un diámetro máximo ≥ 4 cm.
Estadio IIB	Con compromiso parametrial, pero sin compromiso de la pared pélvica.
Estadio III: el carcinoma compromete el tercio inferior de la vagina y/o se extiende a la pared pélvica y/o genera hidronefrosis o disfunción renal y/o tiene compromiso de ganglios pélvicos y/o para-aórticos.	
Estadio IIIA	El carcinoma compromete el tercio inferior de la vagina sin comprometer la pared pélvica.
Estadio IIIB	El carcinoma se extiende a la pared pélvica y/o causa hidronefrosis y/o disfunción renal (sin presencia de otra causa que explique la disfunción renal).
Estadio IIIC	Compromiso de ganglios linfáticos regionales pélvicos y/o para-aórticos sin importar el tamaño tumoral ni su compromiso del estroma.
Estadio IIIC1	Compromiso único de los ganglios pélvicos.
Estadio IIIC2	Compromiso de ganglios para-aórticos.
Estadio IV: el compromiso se extiende más allá de la pared pélvica o hay compromiso (comprobado por biopsia) de la pared mucosa de la vejiga y/o el recto.	
Estadio IVA	Compromiso de órganos adyacentes.
Estadio IVB	Compromiso de órganos distantes.

2.2. FACTORES PRONÓSTICOS:

Los siguientes factores deben ser evaluados con el fin de aportar pronóstico a la enfermedad, estos son:

- Tamaño del tumor.
- Extensión extracervical.
- Compromiso ganglionar.
- Tipo histológico del tumor.
- Profundidad del estroma.
- Invasión linfovascular.
- Compromiso a distancia.

Métodos para estadificación:

- Examen pélvico.
- RM de pelvis.
- La cistoscopia o la rectosigmoidoscopia se realizarán cuando existe sospecha de compromiso, según los hallazgos en la ex-

ploración física y en la RMN, además, si hay sospecha de compromiso, esta debe ser confirmada por biopsia.

- PET/CT para evaluación de compromiso ganglionar y la metástasis a distancia.

2.3. CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA:

En la enfermedad neoplásica, siempre debe confirmarse el diagnóstico por medio de la histopatología. Dentro de los diferentes tipos histológicos, los más comunes son los que ocurren en las células epiteliales, debido a que son estas las células blanco del VPH (41). Estos tipos histológicos pertenecen en su gran mayoría al carcinoma de células escamosas, y en menor proporción al adenocarcinoma de cérvix. Existen también otros tipos histológicos derivados de diferentes tipos celulares estromales presentes en el tejido cervical. En la tabla 3 se presenta la clasificación histopatológica de la OMS para el CCU.

Tabla 3 Clasificación histopatológica de la OMS

Epithelial tumours

1. Squamous tumours and precursors

Squamous cell carcinoma, not otherwise specified	8070/3
Keratinising	8071/3
Non-keratinising	8072/3
Basaloid	8083/3
Verrucous	8051/3
Warty	8051/3
Papillary	8052/3
Lymphoepithelioma-like	8082/3
Squamotransitional	8120/3
Early invasive (microinvasive) squamous cell carcinoma	8076/3
Squamous intraepithelial neoplasia	
Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 3 /	8077/2
squamous cell carcinoma <i>in situ</i>	8070/2

Benign squamous cell lesion	
Condyloma acuminatum	
Squamous papilloma	8052/0
Fibroepithelial polyp	
2. Glandular tumours and precursors	
Adenocarcinoma	8140/3
Mucinous adenocarcinoma	8480/3
Endocervical	8482/3
Intertinal	8144/3
Signet-ring cell	8490/3
Minimal deviation	8480/3
Villoglandular	8262/3
Endometrial adenocarcinoma	8380/3
Clear cell adenocarcinoma	8310/3
Serous adenocarcinoma	8441/3
Mesonephric adenocarcinoma	9110/3
Early invasive adenocarcinoma	8140/3
Adenocarcinoma <i>in situ</i>	8140/2
Glandular dysplasia	
Benign glandular lesions	
Müllerian papiloma	
Endocervical polyp	
3. Other epithelial tumours	
Adenosquamous carcinoma	8560/3
Glassy cell carcinoma variant	8015/3
Adenoid cystic carcinoma	8200/3
Adenoid basal carcinoma	8098/3
Neuroendocrine tumours	
Carcinoid	8240/3
Atypical carcinoid	8249/3
Small cell carcinoma	8041/3
Large cell neuroendocrine carcinoma	8013/3
Undifferentiated carcinoma	8020/3
Mesenchymal tumours and tumour-like conditions	
Mixed epithelial and mesenchymal tumours	
Melanocytic tumours	
Miscellaneous tumours	
Lymphoid and haematopoietic tumours	
Secondary tumours	

2.4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS DIFERENTES ESTADIOS

Para realizar el diagnóstico de las enfermedades limitadas al cuello uterino, la utilización de diferentes técnicas depende de la situación clínica y del tamizaje previo que tenga la paciente, en la mayoría de los casos, la colposcopia + biopsia permiten la realización de un diagnóstico claro a nivel histopatológico (42,43). El espécimen para analizar no debe ser fragmentado y en el reporte se debe mencionar la presencia o ausencia de invasión. El profesional que hace el reporte debe ser un patólogo experto en la materia (25).

Como gran parte de las pacientes afectadas se encuentran en edad reproductiva, se debe tener en cuenta en su manejo el deseo de la preservación de la fertilidad, la edad y la presencia o ausencia de invasión linfovascular.

Si en el reporte de la patología posterior a la conización aparece compromiso tumoral mayor a 5 mm se clasificará como un estadio IB, con una posterior subclasificación dependiendo del tamaño tumoral (44). En el caso de lesiones visibles, una biopsia generalmente puede ser suficiente, pero si no es satisfactoria, puede requerirse una conización (45). La evaluación clínica es el primer paso en la asignación de la estadificación.

Además del examen clínico, se hace necesaria la evaluación mediante imágenes. Se puede utilizar cualquiera de las modalidades de imagen: ecografía -US- (46), TAC (37), RM (47), PET/CT (48,49), para proporcionar información sobre el tamaño del tumor, el estado ganglionar y la diseminación local o sistémica. La RM es el mejor método de evaluación radiológica de tumores primarios mayores de 10 mm (50).

Las imágenes tienen la ventaja de identificar factores pronósticos adicionales, que guían para la elección del tratamiento, principalmente permiten identificar metástasis a ganglios linfáticos (51), invasión parametrial y extensión endocervical (34). Para la detección de metástasis ganglionares mayores de 10 mm, la PET/CT (52,53) es más precisa que la TAC y la RM, con resultados falsos negativos en el 4–15% de los casos (50), sin embargo, la TAC y la RM son técnicas que también presentan una alta sensibilidad para la detección de nodos linfáticos mayores a 10 mm, y son una importante alternativa a utilizar en escenarios en los cuales el PET-CT no esté disponible.

En áreas con una alta prevalencia de tuberculosis e inflamación, en especial en las áreas endémicas del VIH (54), los ganglios linfáticos aumentado de tamaño, no son necesariamente metastásicos, y pueden también ser el resultado de linfadenopatías reactivas posquirúrgicas (55,56). El médico puede tomar la decisión sobre la obtención de imágenes o la biopsia para establecer o excluir metástasis. Esto es especialmente cierto en Estadios avanzados, donde la evaluación quirúrgica de los ganglios linfáticos para-aórticos puede ser utilizada para adaptar el tratamiento de acuerdo con la extensión de la enfermedad. Se puede acceder a ellos mediante cirugía mínimamente invasiva (57,58).

En pacientes con carcinoma invasivo, se debe realizar una radiografía de tórax y valorar si hay hidronefrosis (59,60) (con ecografía renal, pielografía intravenosa, TAC o RM). La vejiga y el recto se evalúan mediante cistoscopia y rectosigmoidoscopia solo si el paciente presenta síntomas clínicos, compromiso de las paredes anterior y/o posterior evidenciado por exploración y/o imágenes (61,62).

La estadificación se definirá después de que todos los informes de imagenología y patología estén disponibles. No se puede modificar más tarde, por ejemplo, en la recurrencia. En algunos casos, la histerectomía se realiza en presencia de un carcinoma cervical invasivo insospechado que se diagnostica posteriormente en la histopatología, dándose el diagnóstico de un tumor inadvertido.

La evaluación de la enfermedad extrauterina debe incluir siempre evaluación del

espécimen a través de biopsia con aguja tru-cut para confirmación o por medio del PET/CT (38).

Hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos, la TAC, la RM y la PET/CT con 18F-FDG y la estadificación quirúrgica se utilizan para estadificar y planificar el tratamiento. En la Tabla 4 se resumen las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas sobre las técnicas diagnósticas en CCU.

Tabla 4 Procedimientos diagnósticos recomendados por las diferentes sociedades científicas en CCU

FIGO 2009	• Recomendados: Rx tórax, Rx esqueleto, pielografía/cistoscopia/proctoscopia (si se sospecha invasión) • Aceptados: TC o RM en caso de estar clínicamente indicadas (no son esenciales)
NCCN 2017	“Estadio I Sin conservación de la fertilidad • Recomendada Rx torácica. En caso de hallazgo patológico, debe realizarse TC sin contraste • Recomendada RM pélvica con contraste (si $\geq$ IB2) • Recomendada PET/TC o TC torácico-abdomino-pélvica Conservación de la fertilidad • Recomendada Rx torácica. En caso de hallazgo patológico, debe realizarse TC sin contraste • Recomendada RM pélvica con contraste (opción preferente). ECO transvaginal si la RM está contraindicada Estadios II a IV • Recomendada PET/TC (opción preferente) o TC torácico-abdomino-pélvico, para descartar metástasis • Recomendada RM pélvica con contraste (opción preferente). ECO transvaginal si RM contraindicada • Si hallazgo incidental de neoplasia de cérvix en una histerectomía, considerar PET/CT o TC torácico-abdomino-pélvico (para la diseminación a distancia) y RM (para la eventual enfermedad residual pélvica). • NCCN recomienda ganglio centinela en tumores de ≤ 2 cm. • Pueden ser opcionales otras pruebas si existe sospecha de metástasis. • PET/TC alternativa a la linfadenectomía o si ha sido positiva, para descartar M. • En estadio IB2, IIA2 o CCLA: se recomienda PET/TC, RM o TC, para planificar la RT
ESMO 2017	Recomendadas: RX tórax, pielografía Opcionales (no alteran el estadio): • TC para detectar adenopatías patológicas • RM para determinar el tamaño tumoral, el grado de invasión estromal, la afectación parametrial y la extensión vaginal/uterina • PET/TC es la técnica más adecuada para valorar afectación ganglionar subcentimétrica y metástasis a distancia • La planificación de la RT se basa en el estadio quirúrgico o bien en la PET/TC

ESGO 2017	Tumor primario: • Recomendada la RM para valorar la extensión pléfica de la enfermedad y guiar el tratamiento. Son opcionales la ecografía transrectal o transvaginal, si se realizan por expertos. La invasión de la vejiga o el recto deben de confirmarse histológicamente. • La cistoscopia y la rectoscopia pueden ser consideradas para conseguir una biopsia en el caso de que existan lesiones sospechas por RM o US. Valoración de la extensión de la enfermedad: • Se recomienda PET/TC o TC toracico-abdominal, para valorar la afectación nodal o a distancia, en CCLA o en pacinetes con enfermedad precoz pero con sospecha de afectación ganglionar por imagen. • La PET/TC está recomendada para planificar la RT en CCLA, previo a tratamiento radical QTRT.
SEOM 2015	Recomendaciones: Rx de tórax, pielografía y cistoscopia y proctoscopia (en el caso de invasión de vejiga o el recto), para definir mejor la FIGO. El resto de técnicas de imagen no modifican el estadio, aparecen opcionales en estadio precoces, pero se recomiendan en CCLA: • RM pélvica es la técnica de imagen preferente para planificar el tratamiento, especialmente en paciente en las que se desea conservar la fertilidad • PET/TC se utiliza para determinar la afectación linfática y la diseminación a distancia
SEGO 2013	Opcional: PET/TC y RM en estadificación inicial en estadios IB2, IIA2, IIB, III y IV como alternativa a la linfadenectomía o en el caso de linfadenectomía positiva, para descartar M1 Opcional: ganglio centinela dentro de protocolos de estudio en estadios III.

2.5. TRATAMIENTO DEL CCU:

El tratamiento del CCU corresponde a un manejo interdisciplinario en el que la radioterapia juega uno de los papeles más importantes (63). Además de la cirugía gineco-oncológica, la quimioterapia con determinadas moléculas citotóxicas y anticuerpos monoclonales puede ser efectiva en algunos estadios particulares de la enfermedad (64,65), además, el uso de radioterapia tiene un rol cada vez más crucial para la terapia, tanto en la neoadyuvancia como en la adyuvancia (66,67). Para aquellos pacientes en fases localmente avanzadas o metastásicas, donde el tratamiento tiene un muy bajo o ausente potencial de ser curativo, los cuidados paliativos y el control del dolor son de vital importancia, pues pueden impactar sobre la calidad de vida de la paciente, y permitir alcanzar un

nivel mayor de tranquilidad mental y de aceptación de la enfermedad (68). Al igual que en la mayoría de las enfermedades neoplásicas, el tratamiento podría ser diferente dependiendo del Estadio tumoral, de esta forma procederemos a dar recomendaciones para el manejo del CCU invasivo de acuerdo con sus diferentes Estadios:

- **Estadio IA1:** el manejo de este tipo de tumor es netamente quirúrgico. La variación en la técnica quirúrgica depende de dos factores principales: 1) Deseo de fertilidad (si aún la paciente se encuentra en edad fértil) y 2) Invasión del espacio linfovascular (LVSI) (44). En mujeres con el deseo de preservar la fertilidad, la conización o la traquelectomía simple son técnicas aceptadas con buena evidencia en los casos en los que no hay LVSI (44,69). En los casos en que LVSI está presente, debe considerarse

la evaluación de los nodos linfáticos regionales e incluso la realización del ganglio centinela, proponiendo una disección de nodos linfáticos pélvicos (PLND) (70–72).

En caso de que los márgenes sean positivos, lo preferible es repetir la conización antes de considerarse una enfermedad más avanzada. La estadificación ganglionar, no está indicada en caso de que no exista compromiso linfovascular. En mujeres que no tienen deseo de fertilidad, o en mujeres que no se encuentran en edad fértil, la histerectomía extrafascial puede ser una opción. En aquellos casos en que la paciente no sea candidata a un manejo quirúrgico debido a enfermedades asociadas, la braquiterapia es una alternativa recomendada.

- **Estadio IA2:** el deseo de fertilidad es también una situación para tener en cuenta en estos casos. Debido al incrementado riesgo de enfermedad diseminada en este Estadio tumoral, si la paciente no tiene deseo de fertilidad, se recomienda realizar histerectomía radical modificada + PLND bilateral + muestreo de ganglios para-aórticos (si es posible) (70). Una alternativa al manejo quirúrgico es la utilización de radioterapia pélvica + braquiterapia (69,73). En caso de que se desee preservar la fertilidad, la conización cervical + PLND bilateral (laparoscópica o extraperitoneal) + muestreo de ganglios para-aórticos (si es posible) está indicado o también se puede realizar traquelectomía abdominal total + PLND + muestreo de ganglios para-aórticos (si es posible) (44,70,71,74).

La realización de la histerectomía luego de tratamiento conservador no está indicada.

- **Estadio IB1:** en este Estadio tumoral, se debe tener en cuenta el riesgo que tiene el tumor de generar invasión regional o a dis-

tancia. Algunas características histológicas e imagenológicas se utilizan para estimar este riesgo. Se considera riesgo bajo cuando la extensión tumoral máxima es menor a 2 cm, cuando la invasión del estroma cervical es menor al 50% y cuando no hay presencia de ganglios linfáticos sospechosos de compromiso en las imágenes realizadas. Para este tipo de tumores de bajo riesgo, se recomienda la realización de histerectomía radical modificada + PLND, o de histerectomía radical modificada (HRM) + RT adyuvante, o HRM + RT pélvica + quimioterapia en dosis bajas, o incluso una alternativa al manejo quirúrgico es la utilización de RT + BT + dosis baja de quimioterapia basada en platinos (70,75). Se deja claro que en aquellos casos en que se realice cirugía como método principal, la RT y QT se utilizarán como terapia adyuvante en los casos en que haya compromiso ganglionar, parametrial o de márgenes positivos. En mujeres jóvenes que desean preservar la fertilidad, se puede realizar una traquelectomía radical, en donde se extirpa el cuello uterino junto con el parametrio seguido de anastomosis del útero con el extremo vaginal. La traquelectomía se puede realizar por vía abierta abdominal, laparoscópica o vaginal. Cuando se planea un abordaje vaginal, los ganglios pélvicos se extirpan primero por vía laparoscópica y se envían a la sección congelada para confirmar la negatividad de los ganglios y luego proceder con la traquelectomía radical por vía vaginal.

- **Estadio IB2 y IIA1:** en este estadio tumoral, la cirugía y la radioterapia ofrecen resultados similares en cuanto al pronóstico oncológico, y cada uno de los tipos de manejo se elegirán de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y a las necesidades propias de la paciente. La cirugía radical debe ser realizada por ginecólogo-oncólogo. Si se detecta compromiso ganglionar,

presencia de márgenes positivos, o compromiso de parametrios se recomienda tratamiento adyuvante con radioterapia + quimioterapia concomitante. En detección inequívoca de compromiso ganglionar por biopsia o PET-CT, se recomienda como tratamiento de elección quimioterapia + radioterapia + braquiterapia.

La evaluación de los ganglios debe ser el primer paso en la indicación del tratamiento quirúrgico. Todos los ganglios centinela y los ganglios sospechosos deben ser enviados a congelación. Si los ganglios centinela no son detectados, se debe realizar linfadenectomía sistemática del lado en el cual no se encuentre el ganglio centinela, o bilateral si es necesario (72).

La utilización de quimioterapia neoadyuvante (CTNA), seguida de cirugía no es recomendada. Hay un nivel de evidencia fuerte para realizar en este estadio tratamiento con RT pélvica + quimioterapia a dosis bajas basada en platinos + braquiterapia (70,76).

- **Estadios IB3 y IIA2:** en este estadio, los tumores son más grandes y la probabilidad de tener márgenes positivos después de la cirugía es alta, necesitando tratamiento adyuvante con RT + QT + BT. Además, los factores de alto riesgo como son ganglios linfáticos positivos, parametrios comprometidos, hace que en estos estadios IB3 hasta IIA2 se recomiende la RT pélvica + quimioterapia concurrente a bajas dosis basada en platinos + braquiterapia, demostrando importante disminución en el riesgo de mortalidad en comparación con RT pélvica sola (44,70).

- **Estadios IIB a IIIA:** en este tipo de pacientes se recomienda tratamiento radical con RT + quimioterapia concurrente a bajas do-

sis basada en platinos (77) + braquiterapia (78). En casos de enfermedad residual posterior a la quimio radiación, recaída central o en casos de persistencia de tumores menores de 4 cm sin enfermedad a distancia, se recomienda realizar exenteración pélvica (79,80).

- **Estadios IIIB a IVA:** en estas pacientes el pronóstico empeora. Las terapias suelen ser agresivas, individualizadas y se basan en manejo multidisciplinar. El manejo ideal consiste en la RT pélvica + quimioterapia concurrente en bajas dosis basada en platinos + braquiterapia + cuidados paliativos. En algunos casos se puede considerar el uso de RT de campo extendido según los hallazgos en el momento de la clasificación del estadio tumoral (81,82) en los casos de persistencia de la enfermedad o de recaída se puede utilizar quimioterapia sistémica (83) o incluso cirugía de rescate, principalmente cuando hay recurrencias (84).

- **Estadio IVB:** el tratamiento de la enfermedad metastásica con compromiso de órganos a distancia consiste principalmente en el cuidado paliativo general, incluyendo la utilización de quimioterapia (85,86) y radioterapia paliativas (87,88). El manejo general dependerá del acceso a los diferentes recursos en el centro en el que se esté dando el manejo. El panorama ideal plantearía la utilización de quimioterapia con intención paliativa + bevacizumab (como inhibidor de la angiogénesis) + RT paliativa individualizada (tratamiento de síntomas como sangrado y descargas vaginales) + cuidado paliativo (70). Se recomienda además en este grupo la búsqueda de posibles ensayos clínicos en los que los pacientes pudieran ser incluidos.

- **Enfermedad recurrente:** se debe tener en cuenta el uso de agentes quimioterá-

picos como el platino, la radioterapia y la localización de la recurrencia para definir posibilidad elección de tratamiento:

- Recurrencia central sin radioterapia previa, lo indicado es QT +RT o RT + BT.
- Recurrencia central con RT previa: Se recomienda exanteración.
- Recurrencia no central sin RT: Se recomienda QT y RT directa al tumor.
- Recurrencia no central previa RT: RT directa al tumor con o sin QT o resección quirúrgica con RT intraoperatoria o QT + Bevacizumab o cuidados paliativos.

En caso de segunda recurrencia, se prefiere estudio clínico o QT, en conjunto con cuidado paliativo (tabla 5).

El GMMCC, ha llegado al consenso de que se brindará siempre el mejor enfoque qui-

rúrgico posible, buscando la conservación de funciones fisiológicas básicas como la función urinaria y defecatoria, al igual que de la función reproductiva en aquellas mujeres que así lo deseen, y cuyo estadio de CCU así lo permita.

El entrenamiento y la formación continua son también un objetivo del GMMCC para C/Can, pues debe asegurarse contar con los recursos humanos capacitados para realizar procedimientos de alta complejidad, que permitan alcanzar los objetivos ya mencionados.

En determinados escenarios, se preferirá el abordaje quirúrgico abierto radical por encima de la cirugía mínimamente invasiva, pues evidencia reciente apoya el uso de la laparotomía, con el fin de disminuir el riesgo de invasión regional y a distancia, y la recaída de la enfermedad.

Tabla 5 Impacto de los diferentes medicamentos en la SG y la SLP

Agente	N	RC + RP	SLP	SG
Bevacizumab	46	11	3,4	7,3
Topotecan	94	13 - 19	2,1 - 2,4	6,4 - 6,6
Vinorelbine	44	14	-	-
Gemcitabina	22	5	2,1	6,5
Paclitaxel unido a albúmina	35	29	5,0	9,4
Docetaxel	23	9	3,8	7,0
Pemetrexed	72	14 - 15	2,5 - 3,1	7,4 - 8,8
Irinotecan	42	21	4,5	6,4
Sunitinib	19	0	3,5	-
Erlotinib	28	0	1,9	5,0
Lapatinib	78	5	4,2	9,7
Pazopanib	74	9	4,5	12,7
Doxorrubicina liposomal pegilada	27	11	3,2	8,9

* RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; SLP: supervivencia libre de progresión; SG: sobrevida global

2.5.1. Especificaciones sobre la quimioterapia

- Régimen de quimioterapia para enfermedad avanzada sin metástasis a distancia: se recomienda el uso de quimioterapia concurrente a radioterapia, basada en platinos, a dosis bajas (44,69,70,89). Diferentes estudios han demostrado que la quimioterapia concurrente a la radioterapia uterina y para-aórtica es superior a la radioterapia sola (90–92). Las dosis y medicamentos se especifican en la tabla 6.
- Régimen de quimioterapia para estadios avanzados (metástasis) o de recurrencia: el manejo ideal con quimioterapia corresponde al uso de una terapia basada en platinos,

así podrá administrarse cisplatino + paclitaxel + bevacizumab (93), o carboplatino + paclitaxel + bevacizumab (especialmente en pacientes que ya han recibido cisplatino) (69,94). El manejo mínimo debe incluir tratamiento con un platino + un taxano. Las dosis y medicamentos se especifican en la tabla 6.

- Quimioterapia no disponible en la concurrencia con radioterapia: con el fin de evitar algún tipo de retraso en el inicio de la radioterapia en aquellos pacientes quienes para su estadio se les indica manejo con RT + QT, el consenso de expertos determina que en los casos en que por alguna razón se retrase el acceso a la QT, no se debe retrasar la provisión de RT.

Tabla 6 Dosis y posología de las diferentes combinaciones de quimioterapia para el manejo de CCU en sus diferentes fases

MEDICAMENTO	DOSIS Y POSOLOGÍA
Cisplatino	Cisplatino 40 mg/m ² IV una vez por semana hasta alcanzar 6 (la dosis total no debe exceder 70 mg/semana).
Cisplatino + 5-fluorouracilo	Días 1–5 de radioterapia: Cisplatino 75mg/m² IV por 4 horas, seguido por 5-FU 4,000 mg/m² IV por 96 horas (debe iniciarse la quimioterapia en las primeras 16 horas después de la sesión de radioterapia). Repetir el ciclo cada 3 semanas por 2 ciclos adicionales Ó Días 1 y 29: Cisplatino 50mg/m² IV (4 horas antes de radiación de haz externo) a 1 mg/minuto en conjunto con la hidratación estándar + Días 2–5, y 30–33: 5-FU 1,000 mg/m² IV en infusión continua por 24 horas (dosis total de 4,000 mg/m² por cada curso).
Cisplatino + Paclitaxel + Bevacizumab	Día 1: Cisplatino 50 mg/m² IV + Paclitaxel 135-175 mg/m² IV + Bevacizumab 15 mg/kg IV. El ciclo debe repetirse cada 21 días hasta que ocurra progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o respuesta completa de la enfermedad.
Carboplatino + Paclitaxel + Bevacizumab	Día 1: Paclitaxel 175 mg/m² IV infundidos en 3 horas seguido por 1 hora de infusión de Carboplatino IV con una AUC de 5 mg/mL/min + Bevacizumab 15 mg/kg IV. El ciclo debe repetirse cada 3 semanas hasta alcanzar un máximo de 6 ciclos, haya progresión de la enfermedad, o aparezca toxicidad inaceptable.

MEDICAMENTO**DOSIS Y POSOLOGÍA**Cisplatino +
Paclitaxel**Día 1:** Paclitaxel 135mg/m² IV por 24 horas**Día 2:** Cisplatino 50mg/m² IV a una tasa de 1 mg/minuto.

El ciclo debe repetirse cada 3 semanas hasta alcanzar 6 ciclos.

Carboplatino +
Paclitaxel**Day 1:** Paclitaxel 175mg/m² IV por 3 horas, seguido de 1 hora de infusión de carboplatino IV con una AUC de 5 mg/mL/min.

El ciclo debe repetirse cada 3 semanas hasta alcanzar 6 ciclos, hasta que la enfermedad progrese o hasta la aparición de toxicidad inaceptable.

2.5.2. Especificaciones sobre la radioterapia:

La RT se ha convertido en una herramienta esencial en el manejo del cáncer (95). En el tratamiento del CCU, la RT juega un papel crucial en el tratamiento de las lesiones localmente avanzadas o con compromiso regional, al igual que en el manejo de recurrencias y como estrategia de cuidado paliativo (96,97).

A continuación, se presentan algunas recomendaciones necesarias para la correcta utilización de RT en CCU:

- En caso de mujeres premenopáusicas, con deseo de fertilidad, con requerimiento de tratamiento con RT, se debe realizar inicialmente una transposición ovárica (98) por parte del servicio de ginecología oncológica, con el fin de disminuir la cantidad de radiación que podrían recibir los ovarios. A este tipo de mujeres se les debe realizar radioterapia de intensidad modulada (99).
- Para realizar un tratamiento de radioterapia en pacientes con CCU, se debe realizar simulación con CT pélvico o abdomino pélvico si el caso así lo requiere. La paciente debe tener una preparación adecuada tanto del recto como de la vejiga para garanti-

zar la reproducibilidad y disminuir la dosis a estos órganos durante el tratamiento.

- Las indicaciones de RT ya se han dejado claras previamente en esta guía. Se recomienda administrar dosis totales de la siguiente forma:

Estadios IA1 y IA2:

Dosis total a punto A 70-80 Gy.

Estadios IB1-IIA1:

Dosis total a punto A 80-85 Gy.

Estadios IB2-IIA2, IIB, III y IVA:

Dosis total en el punto A $\geq$ 85 Gy.

- RT adyuvante postoperatoria: debe realizarse RT adyuvante postoperatoria en aquellas pacientes que hayan sido llevadas a cirugía oncológica y que presenten criterios mayores para adyuvancia (márgenes positivos, ganglios linfáticos comprometidos, parámetros comprometidos) o en caso de cirugía no oncológica con factores de mal pronóstico como tumor grande, invasión estromal o linfovascular. En caso de no presentar criterios mayores, se recomienda la utilización de los criterios de Sedlis (89) (Tabla 7), para definir la Necesidad de adyuvancia con RT.

Tabla 7 Criterios de Sedlis para definir uso de radioterapia adyuvante

Criterios clásicos	Criterios GOG 92 (Sedlis)
Compromiso del espacio linfovascular	Compromiso linfovascular (+), invasión estromal 1/3 profundo, cualquier tamaño tumoral
Invasión estromal profunda	Compromiso linfovascular (+), invasión estromal 1/3 medio, tamaño tumoral >2 cm
Tamaño tumoral ≥2 cm	Compromiso linfovascular (+), invasión estromal 1/3 superficial, tamaño tumoral >5 cm Compromiso linfovascular (-), invasión estromal 1/3 profundo o medio, tamaño tumoral >4 cm

- La Braquiterapia siempre debe realizarse guiada por imagen para delimitación de volúmenes objetivo y de órganos sanos, idealmente debería utilizarse la RM, sin embargo, este tipo de técnica no suele estar disponible en muchos centros de atención en nuestro medio, por ende, se considera suficiente la utilización de TAC, y de RM cuando sea posible.

- Educación acerca de síntomas, potencial recurrencia y efectos secundarios a largo plazo.

- Prescripción de terapia de reemplazo hormonal individualizada y guiada por expertos.

- Imágenes y laboratorios deben ser basados en los síntomas y hallazgos clínicos.

2.6. SEGUIMIENTO DE LAS MUJERES QUE HAN FINALIZADO EL TRATAMIENTO PARA CCU

El esquema de seguimiento debe ser individualizado, teniendo en cuenta los factores de riesgo, la modalidad de tratamiento, la estimación del riesgo y los eventos adversos. En general se recomienda hacer consultas de control cada 3 o 4 meses durante los primeros 2 años y luego cada 6 a 12 meses, hasta completar 5 años.

En cada visita se debe evaluar lo siguiente:

- Examen físico, incluyendo examen pélvico bimanual.
- Evaluación de los eventos adversos del tratamiento.

- Según la NCCN, la guía más detallada en este contexto, la PET/TC es de elección en pacientes con sospecha clínica de recaída local (sensibilidad del 86%, especificidad del 87%) pero también en pacientes con sospecha de metástasis (sensibilidad del 90%, especificidad del 99%). La misma guía puntualiza que la recomendación de la PET/TC es en pacientes a las que se les ha realizado un tratamiento completo radical, con estadio FIGO Ib2 o superior, o bien que requerían RT adyuvante o QT-RT concomitante por factores de riesgo (adenopatías positivas, parametrio afecto, márgenes positivos o factores de riesgo locales) para descartar metástasis a distancia. Puntualiza que se puede realizar una PET/TC con contraste yodado intravenoso entre 3 y 6 meses tras la finalización del tratamiento, para valorar la respuesta e intentar detectar las pacientes con recidiva/persistencia de enfermedad localizada que puedan beneficiarse de otros tratamientos curativos como la exenteración (100,101).

3. CUIDADO PALIATIVO

El cuidado paliativo (CP) es una especialidad relativamente nueva, que ha tenido su evolución en las últimas cinco décadas, con un crecimiento exponencial desarrollado principalmente en la última década. El CP nace como una estrategia médica que busca controlar y disminuir el dolor y el sufrimiento de pacientes cuyas patologías son de difícil curación, o prácticamente incurables, situación que se vive hoy en día con el aumento en la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles (102), secundaria al aumento de la esperanza de vida y por consiguiente la acumulación de años de edad, uno de los principales factores de riesgo para el cáncer (103,104). El CP busca proveer los cuidados complementarios e integrales en el final de la vida, buscando mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades en estadios avanzados (es importante aclarar que no solamente deben proveerse en el final de la vida) (105). El CP va dirigido también a los familiares del paciente, pues estos también desarrollan diferentes desórdenes de índole psicológico y psicosomático, consecuencia de las diferentes actividades y emociones que giran en torno al paciente con cáncer (106,107).

A pesar de que el CP es aplicable en múltiples patologías crónicas, su uso es especialmente importante en los pacientes que sufren padecen algún tipo de neoplasia (108). Esta importancia es tal que, en diferentes actualizaciones de recomendaciones de salud pública para el manejo del cáncer impuestas por la OMS, el CP debe hacer parte de los cuatro pilares fundamentales de un sistema nacional de control de cáncer (109).

Los cuidados paliativos buscan mejorar la calidad de vida de las pacientes a través del control de sus síntomas. Como su fin no es curar la enfermedad, muchos creen que los cuidados paliativos se limitan al manejo de pacientes en final de vida. Pero ésta no es la realidad. Muchos pacientes se pueden ver beneficiadas de una intervención por el equipo de CP en cualquier estadio de la enfermedad neoplásica, incluso desde los inicios de ésta. El objetivo es poder vivir más tiempo en óptimas condiciones; y esto se logra mediante la atención de sus necesidades físicas, emocionales, familiares/sociales, y espirituales.

La legislación colombiana contempla desde el 2014 a los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes, plasmado en la Ley 1733 o Ley Consuelo Devis, donde se refiere a ellos como *“cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible donde el control del dolor y otros síntomas, requieren además del apoyo médico, social, espiritual, psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. La atención paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal.”*

3.1. Objetivos

- Respetar y preservar la autonomía de la paciente.
- Lograr el control de síntomas.
- Brindar información y comunicación adecuadas.

- Responder a sus necesidades espirituales.
- Asegurar la continuidad en la asistencia.
- Evitar prolongación inadecuada del proceso de la muerte.
- Apoyar y ofrecer soporte emocional al paciente, familiares y allegados.
- Respetar y apoyar las preferencias y voluntad de los pacientes.
- Brindar atención en el duelo.
- Aliviar carga de cuidadores y familiares.
- Incrementar la satisfacción de la familia con los cuidados brindados.
- Fortalecer relación con seres queridos.
- Prevenir consultas al servicio de urgencias y hospitalizaciones innecesarias.
- Controlar la estancia hospitalaria prolongada y disminuir el efecto en costos, en disponibilidad de camas y menor rentabilidad.

¿Qué pacientes con CCU requieren CP?: normalmente, se considera que aquellas mujeres con CCU en estadios localmente avanzados o metastásicos deben ser valoradas y tratadas por un servicio óptimo de CP, pues es en estas fases en las que comienzan a presentarse los síntomas más molestos e incapacitantes asociados a la enfermedad (110). A pesar de lo anterior, el GMMCC, considera que toda mujer con diagnóstico de cáncer de cuello uterino debe ser valorada por CP, con el fin de generar una visión global e integral de su situación, y detectar la necesidad de algún tipo de intervención paliativa en el momento, o la posible necesidad de esta en alguna de las fases de la enfermedad.

Es importante tener en cuenta la evolución de esta patología. Debido a su lento crecimiento, las mujeres pueden padecer de CCU por mucho tiempo, antes de empezar a presentar sintomatología dolorosa u otros síntomas. Todos los tratamientos traen consigo el riesgo de presentar efectos secundarios, con diversidad de síntomas que deberán atenderse para evitar el deterioro de la calidad de vida de la paciente.

A medida que la enfermedad avanza, si las terapias instauradas no logran controlar la enfermedad, complicaciones más complejas pueden aparecer. Entre ellas están los dolores pélvicos, la falla renal obstructiva por compromiso de vejiga y/o uréteres, fístulas entero-vaginales o entero-vesicales, dolor por compresión/invasión nerviosa, flujo vaginal persistente, hemorragia vaginal, entre otros. Además de la incomodidad que generan estas complicaciones, está el riesgo latente y cada vez más presente de que la lleve a la muerte.

¿Quiénes deben encargarse de proveer el CP?: La atención en cuidados paliativos debe brindarse a todo nivel, con personal capacitado para ello, de acuerdo con la complejidad que presenten las pacientes. A mayor complejidad, será necesario tratarlas en niveles de atención superiores, con equipos de atención en cuidados paliativos con mayor preparación, o especialistas en esta área si fuera necesario. Es ideal que los equipos sean compuestos por un grupo de profesionales que incluya al médico, enfermera, asesor espiritual, psicóloga, y/o trabajador social, entre otros. Se recomienda lograr una coordinación de los diferentes niveles y profesionales en red, bajo la dirección de un médico paliativista, y así lograr la atención integral idónea y continua para el paciente.

¿Cuáles son los síntomas que con mayor frecuencia deben ser atendidos en las pacientes con CCU?:

La intervención de CP en CCU está dirigida tanto a la paciente como a sus familiares y acudientes directos. Se busca aliviar los síntomas físicos asociados a la enfermedad, además de los síntomas psicológicos y otras necesidades presentes en el paciente y su entorno social (111,112). Algunos de éstos a tratar se enumeran a continuación (113):

Síndromes dolorosos:

- Plexopatía lumbosacra.
- Dolor somático por invasión de la pared pélvica.
- Dolor visceral.

Generales:

- Deshidratación.
- Caquexia, anorexia.
- Fatiga y debilidad.
- Edema de miembros inferiores.
- Úlceras por presión.

Gastrointestinales:

- Estreñimiento.
- Proctitis post-radioterapia.
- Náuseas y vómito.
- Pseudo-obstrucción u obstrucción intestinal maligna.
- Fístulas recto-vaginales

Genitourinarias:

- Descargas vaginales.
- Sangrado vaginal.
- Cistitis
- Uropatía obstructiva (hidronefrosis)
- Insuficiencia renal secundaria
- Fístulas vesico-vaginales

Neurológicos:

- Encefalopatía urémica.
- Delirium
- Marcha claudicante.

Psicológicos:

- Depresión.
- Ansiedad.
- Miedo a la muerte.
- Duelo anticipatorio.

Impacto social:

- Red de apoyo deficiente.
- Abandono de pareja.
- Historia de abuso sexual

Intervenciones de CP posibles para el manejo de algunos de los síntomas padecidos por pacientes con CCU:

Control del dolor: Las pacientes con cáncer de cuello uterino pueden padecer dolores de distintos tipos: visceral, somático o neuropático, dependiendo de las estructuras comprometidas. Se pueden seguir las recomendaciones de la OMS, utilizando AINES por corto tiempo y paracetamol en los casos de dolor leve, opioides débiles en dolor moderado, y opioides fuertes para los cuadros de dolor severo. El dolor de características neuropáticas puede resultar un reto para el médico tratando el dolor de estas pacientes, pues no suelen responder a la anterior medicación y es necesario introducir a otro grupo de fármacos que van a actuar como coadyuvantes para el manejo analgésico de este tipo de dolor. Aquí se incluyen antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, anticonvulsivos, antagonistas de receptores NMDA (Ketamina), entre otros.

Es muy posible que el manejo de dolores severos requiera la intervención específica del médico especialista en dolor y cuidados paliativos. Estas pacientes no solo se pueden ver beneficiadas del manejo con todos esos medicamentos, sino también con intervenciones mínimamente invasivas como bloqueos simpáticos o neurolíticos, entre otros. Los bloqueos simpáticos lum-

bares, bloqueos de plexo hipogástrico superior y a nivel presacro se utilizan comúnmente en el manejo de dolor de pacientes con este tipo de patología.

Es clave tener en cuenta las siguientes 5 recomendaciones a la hora de utilizar analgésicos en los pacientes con cáncer en general para poder brindar alivio el mayor tiempo posible:

- Utilizar la vía oral, acompañado de un vaso de agua.
- Administración regular, con un intervalo controlado por reloj.
- Dosis analgésica nocturna puede ser modificada para evitar que despertarse en la mitad de la noche para administrar un analgésico que venía cada 4 horas. Se puede incluso duplicar la última dosis de la noche.
- Fármacos coadyuvantes puede llegar a ser necesarios en el manejo de dolores óseos o en dolores de características neuropáticas.

El tratamiento ideal para el dolor asociado a cáncer está fundamentado en la utilización de medicamentos opiáceos, y debe administrarse de forma escalonada, iniciando con opioides de baja potencia y aumentando la dosis progresivamente hasta que se requiera un opioide de mayor potencia (rotación de opioides) (114,115). La utilización de otros medicamentos analgésicos en sinergia con los opioides se recomienda en casos de dolor de tipo neuropático, donde los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), juegan un papel importante (116-118). Cuando el dolor se asocia al compromiso local del tumor por invasión regional o por metástasis ósea, la radioterapia puede ser también una opción útil que disminuye significativamente el dolor (119).

Síndrome caquexia-anorexia: una pérdida de peso balanceada puede presentarse con la progresión de la enfermedad hacia un estadio terminal de final de vida. Algunas intervenciones para mejorar el apetito son:

- La dieta fraccionada (pequeñas cantidades, varias veces en el día).
- Ofrecer los alimentos de su preferencia.
- Presentarlos de una manera agradable para la vista en el plato.
- Uso de medicamentos para la estimulación del apetito como Acetato de Megestrol (160 mg al día) o prednisolona (5-15 mg/día).

Flujos vaginales: es posible que las mujeres con carcinoma del cuello uterino experimenten la salida de flujo vaginal amarillento, sanguinolento, o maloliente. Esto puede estar compuesto por sangre, pus, tejido necrótico, orina, materia fecal, o una mezcla de varios de estos. Las bacterias crecen en este tejido enfermo y es muy difícil erradicarla por completo. Algunas estrategias para su manejo son:

- Utilizar toallas sanitarias o pedazos de tela limpia para colocar en su ropa interior y cambiar continuamente. Se deberá proteger la piel con vaselina o alguna crema que contenga óxido de zinc. (*1)
- Para disminuir el crecimiento bacteriano se puede empaquetar la vagina por unas pocas horas con pedazos de tela empapados en una solución de agua limpia y bicarbonato (1 cucharada/ 500 ml de agua) o vinagre 1(1 parte/4 partes de agua). También se puede preparar una solución antibiótica con metronidazol (macerar 10 tabletas de 200 mg y mezclar con 500 ml de agua hervida). (*1)

- Estas mismas preparaciones se pueden aplicar en duchas vaginales, teniendo precaución de no ocasionar sangrado.

- Si es necesario, se puede utilizar manejo antibiótico oral con Doxiciclina o Amoxicilina + metronidazol. Si se evidencia sobreinfección con hongos, se puede agregar al manejo fluconazol 100 diarios vía oral por una semana, ketoconazol 200 mg al día vía oral por una semana, o un óvulo vaginal de nistatina diariamente por 14 días.

- Aromatizar la habitación con velas de olores y tener buena circulación de aire.

Sangrado vaginal: el empaquetamiento vaginal es una medida útil, sobre todo en situaciones de sangrado agudo, buscando la finalización rápida y eficiente de la hemorragia (120,121). En mujeres que se presentan con un sangrado crónico, que se manifiesta con múltiples sangrados agudos, se recomienda la utilización de otras estrategias para un control a largo plazo del sangrado vaginal, algunas de estas intervenciones incluyen la embolización de arterias uterinas, el ligamiento de arterias uterinas, la resección quirúrgica y la utilización de técnicas de radioterapia como el ortovoltaje transvaginal, la teleterapia con fracciones a altas dosis y la braquiterapia (122). Según una revisión sistemática de Cochrane Library, no hay evidencia suficiente en la actualidad para definir qué tipo de intervención es más efectiva, por ende, en la actualidad se recomienda elegir el tratamiento que mejor se adapte a la situación clínica y social de la paciente (120).

Astenia y adinamia: usualmente mejora con la optimización de la alimentación, asegurando el descanso, y promoviendo la actividad física. Se debe descartar la presencia de síndromes depresivos que de-

ban ser tratados. Por otro lado, hay estudios que consideran el uso de esteroides, progestágenos, testosterona, talidomida y psicoestimulantes (metilfenidato) para psicoestimulantes (123).

Linfedema: edema de una o ambas extremidades que suele acompañarse de adenomegalias inguinales que impiden el adecuado drenaje linfático. No hay terapia que lo elimine, pero puede aliviarse con las siguientes recomendaciones:

- Elevación de la extremidad + vendaje.

- Cuidados de la piel con baño suave y masajes con vaselina.

- En caso de presentarse con zonas eritematosas y los ganglios muy sensibles, puede ser que esté cursando con linfangitis (infección) que puede ser tratada con eritromicina oral 500 mg cada 6 horas x 14 días. (*)

Estreñimiento: las deposiciones secas, duras y escasas suelen presentarse en pacientes que permanecen en cama y como efecto secundario de varios de los medicamentos, analgésicos principalmente, que reciben. Una dieta rica en fibra natural (vegetales verdes, zanahoria, nueces molidas, semillas de sémola o calabaza. Se debe mantener con adecuada hidratación, y tener algo de actividad física si es posible. Si está recibiendo opioides, el uso de laxantes puede ayudar a controlar este síntoma. El manejo de la impactación fecal implica uso de enemas y/o extracción manual por enfermera capacitada para esto.

Diarrea: Esta puede resultar de una infección gastrointestinal o secundario a alguno de los manejos dados en el tratamiento de su enfermedad de base (quimioterapia y/o radioterapia).

- Importante ayudarlo con el aseo y evitar la irritación de la zona perianal.
- Asegurar hidratación continua y una dieta astringente.

Ansiedad y depresión: la presencia de alguno de estos síntomas psiquiátricos que comprometen el afecto es bastante frecuente en los pacientes oncológicos (124,125). Los pacientes que se presentan con ansiedad o depresión presentan mayor dificultad para ser adherentes a otros manejos paliativos, disminuyen sus tasas de control del dolor (126,127), y tienen una tendencia a la perpetuación del dolor (128), por lo cual, el control de la salud mental resulta de vital importancia en el PC (122). No existe evidencia suficiente para definir una intervención superior para el manejo de ansiedad y depresión en pacientes con cáncer. Se recomienda la utilización de farmacoterapia con medicamentos antidepresivos y/o ansiolíticos en conjunto con intervenciones psicoterapéuticas e incluso, la utilización de consejería espiritual en aquellos pacientes que se identifiquen como candidatos (129).

El CP debe proveerse de forma individualizada, tratando de identificar todas las molestias somáticas y mentales que pueden afectar la calidad de vida del paciente al final de la vida. Una buena comunicación es indispensable.

Para la mayoría de las mujeres es muy importante poder mantenerse activas, sentirse útiles, y en control de sus vidas. Es necesario comprender esto, pues con la buena intención de cuidar de ellas, se puede correr el riesgo de impedirles actividades o incluso involucrarse en toma de decisiones importantes para su vida. Las relaciones sociales, familiares, y de pareja también se ven afectadas por esta enfermedad. Con frecuencia se sienten rechazadas por padecer esta enfermedad, y un simple abrazo o toma de mano puede ser la manera de expresar un mensaje contrario.

Así como se debe atender las necesidades de la paciente con cáncer de cuello uterino, también es importante evaluar aquellas de sus familiares y cuidadores. Detectar cansancio y prevenir la claudicación del cuidador es importante. Concientizar acerca de buscar ayuda adicional en el cuidado de la enferma puede minimizar el riesgo de las anteriores. Una buena y efectiva comunicación con ellos puede también evitar la “conspiración del silencio” y disminuir el estrés en la familia.

Dentro del manejo paliativo, es necesario tener presente complicaciones adicionales como la obstrucción intestinal maligna, las hemorragias masivas, la compresión medular, y la uropatía obstructiva.

4. ENFERMERÍA ONCOLÓGICA

Todos los actores involucrados en la detección, confirmación diagnóstica y tratamiento del cáncer tienen la responsabilidad de garantizar la atención oportuna, sin demoras ni barreras de acceso a los pacientes. Esta integralidad en la atención cumplirá con los lineamientos de:

- Eliminar las barreras de acceso a los pacientes y sus familias.
- Simplificar los trámites administrativos para los pacientes y sus familias
- Garantizar el acceso a todos los servicios que requiere el paciente de ser posible en una misma IPS, evitando la fragmentación del servicio.
- Solicitar la autorización integral, por una única vez (dependiendo de la evolución del paciente, conforme al plan que determine el médico tratante) y por la totalidad del tratamiento de todos los servicios requeridos.
- Garantizar los servicios psicosociales complementarios en salud.

El personal de Enfermería tiene un rol muy importante en el equipo multidisciplinario, involucrado en el cuidado de pacientes con cáncer de mama, ya que interviene en todo el proceso de la enfermedad, desde detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes, que involucra los lineamientos de integralidad de atención a los pacientes y su familia.

Las enfermeras en el grupo multidisciplinario deberán coordinar los recursos sanita-

rios, psicosociales y la continuidad de los cuidados en este tipo de paciente.

El objetivo del acompañamiento de Enfermería es el conocer paso a paso el proceso que lleva la persona durante el desarrollo de su enfermedad, logrando brindar una atención integral y humanizada al paciente y su familia, a través de:

- El establecimiento de estrategias de intervención, que propicien una relación de calidez con el paciente y a la vez, faciliten la educación en torno a sus necesidades en salud y empoderamiento en el manejo de su enfermedad.
- La identificación y mitigación de factores de riesgo que puedan comprometer la adherencia al tratamiento.
- La disminución de las barreras administrativas de atención, estableciendo canales de comunicación efectivos, entre Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), Institución Prestadora de Salud (EPS), el personal de salud y el paciente y su familia.

Estos resultados se lograrán a través del seguimiento y evaluación a la gestión de prestación de servicios y a los resultados en salud, a través:

Rol clínico:

- Asegurar el desarrollo del plan de tratamiento de acuerdo con lo planificado, conduciendo al paciente a través de los diversos servicios

- Cumplimiento de la guía: Manejo de protocolos de acuerdo con las guías estandarizadas por patología.
- Manejo de catéteres centrales: inserción, curación y mantenimiento.
- Manejo de complicaciones en Radioterapia (Radiodermatitis)
- Manejo de complicaciones quirúrgicas (manejo de heridas, linfedema, complicaciones asociadas.)
- Manejo de Quimioterapia (Protocolos, manejos de extravasación, manejo de signos y síntomas, Manejo de complicaciones quimioterápicas)
- Manejo de inmunoterapia.
- Manejo de Terapia Hormonal.
- Derivación de los pacientes en situaciones agudas a los servicios adecuados.

Rol en cuidado paliativo:

- Manejo del dolor
- Apoyo emocional
- Evaluación de toxicidades
- Manejo de signos y síntomas

Rol educativo:

- Prevención de los efectos evitables de los tratamientos, mediante educación para el autocuidado del paciente, durante todo el proceso de enfermedad.
- Empoderamiento al paciente y familia sobre los cuidados a realizar, de acuerdo con

el tratamiento, para reducir o eliminar circunstancias evitables.

Rol administrativo:

- Gestión de las barreras organizacionales en la aplicación del plan terapéutico; si es necesario, actuando de forma preventiva y contingente y estableciendo canales de comunicación efectivos (EAPB e IPS).
- Referente para el equipo multidisciplinar y para el paciente y su familia.
- Brindando oportunidad en la atención y precisando indicadores que permitan impactar en las complicaciones agudas y tardías y supervivencia libre de enfermedad.

- Gestión del riesgo a través de seguimiento de los indicadores de oportunidad que permiten tomar decisiones administrativas y clínicas.

Rol integrativo:

- Actividades integrativas: Aplicación de técnicas que disminuyan la ansiedad (musicoterapia, cuentoterapia, bailoterapia, aromaterapia, etc).
- Grupos de apoyo (manejo de autoimagen, prótesis, pelucas etc.)

Rol investigativo:

- Brindando datos que aporten investigación y registro de la información.
- Generando conocimiento en buenas prácticas de manejo

Es importante concentrar todas estas actividades hacia la orientación del equipo multidisciplinario en maximizar la calidad

de vida de las pacientes, mientras están en el tratamiento. Revisemos los efectos secundarios más comunes relacionados con el tratamiento y cómo enfrentarlos. Los efectos secundarios físicos pueden permanecer después de terminado el tratamiento, efectos secundarios a largo plazo. A los efectos secundarios que suceden meses o años después del tratamiento, los denominan efectos tardíos. El tratamiento de los efectos secundarios a largo plazo y los efectos tardíos, son una parte importante de la atención para sobrevivientes.

Las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia: se recetarán medicamentos para ayudar a controlarlos. Se trabajará con la nutricionista, que puede proporcionar consejos sobre cómo comer y cómo mantenerse hidratado durante la quimioterapia.

La fatiga: La fatiga es una sensación de cansancio extremo. El médico puede tratar la fatiga con medicamentos recetados. El ejercicio también puede ayudarle.

El quimiocerebro: Problemas asociados con la memoria, la atención y la concentración. Recomendar ejercicios para conservar la memoria.

El linfedema: Acumulación anormal de líquido en los tejidos blandos debido a un bloqueo en el sistema linfático, inflamación dolorosa. Referir al paciente a un programa de ejercicios especiales enseñados por personal capacitado para reducir estos efectos secundarios, a través de: **Drenaje linfático manual (MLD). Ejercicio. Compresión. Terapia descongestiva completa (CDT). Protección de la piel. Elevación de la extremidad. Tratamientos láser de bajo nivel (LLLT). Medicamentos. Terapia física.**

La pérdida ósea: Algunas terapias hormonales y quimioterapias pueden causar pérdida ósea, aumentando así el riesgo de fracturas óseas; hay que ayudar a optimizar su salud ósea y ejercicios que fortalecen sus músculos.

La neuropatía periférica: Sensación de hormigueo en las manos y los pies, también puede ser doloroso. Interconsultar a especialista en neuropatía periférica y manejo del dolor, que brinde medicamentos para aliviar la neuropatía.

El riesgo de infección: Desarrollar un plan de control de infección es muy importante en la reducción de su riesgo, durante los tratamientos contra el cáncer y mejorar su calidad de vida durante la quimioterapia.

El dolor: Controlar el dolor puede exigir diferentes enfoques, por lo que es importante ser tan detallado como sea posible al describir el dolor, para poder controlarlo de la mejor manera.

Cambios físicos: Tanto el cáncer como su tratamiento pueden cambiar el aspecto e incluyen: Pérdida de cabello, Aumento o pérdida de peso, Cicatrices de cirugía, Pérdida de un órgano, extremidad o seno.

Cambios emocionales: El cáncer interrumpe muchas partes de la vida de una persona, desde las relaciones hasta el trabajo y los pasatiempos. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de recuperación, también puede obligarlo a hacer cambios en su futuro y lidiar con la posibilidad de morir. Durante este tiempo, puede sentir muchas emociones diferentes: Tristeza, Ansiedad, Soledad o sensación de ser diferente de los demás, Miedo, Ira, Frustración, Culpa, Sentirse fuera de control, Un cambio en su forma de pensar sobre sí y el futuro.

Pero también muchos cambios positivos emocionales, espirituales o intelectuales: Una apreciación por la fuerza de su cuerpo, Paz, Gratitud, Conciencia y apreciación de que la vida es corta y especial, Agradecido por nuevas relaciones importantes con cuidadores y otros pacientes, Un cambio en las prioridades, claridad sobre el significado en la vida y las metas personales.

Es importante dejarlo expresar todas estas emociones y brindar las herramientas y alternativas para manejarlas a través de la enfermera con rol integrativo.

Los cuidadores también cumplen un papel muy importante en el proceso de las pacientes, ellos asumen diferentes responsabilidades según se requieran:

- Proporcionar apoyo y aliento.
- Conversar con el equipo de atención en salud.

- Administrar medicamentos.
- Ayudar a manejar los síntomas y efectos secundarios.
- Coordinar las citas médicas.
- Llevar al paciente a las citas.
- Asistir con las comidas.
- Ayudar con las tareas domésticas.
- Manejar problemas con el seguro y la facturación.

Se puede aconsejar a los pacientes llevar un diario para hacer una lista de todos los medicamentos, quimioterapia y tratamientos específicos, incluyendo su dosis y la frecuencia con que se toman, y permitirle comunicarlo y expresar todas sus dudas al respecto y realizar seguimiento de su control.

5. REVISIÓN DE EVALUACIONES ECONÓMICAS

Los sistemas de salud se ven enfrentados a dos tipos de cargas de la enfermedad oncológica, a saber: la carga epidemiológica del cáncer, y la carga económica del cáncer.

Ya se ha descrito algunos aspectos conceptuales en el capítulo de introducción. Es claro que la toma de decisiones en salud pública debe considerar aspectos tanto de efectividad como del costo de una determinada tecnología en salud. Es en este escenario en que surge las evaluaciones

económica como mecanismo de apoyo a la toma de decisiones (130,131). En Colombia, las evaluaciones de tecnología en salud específicamente las evaluaciones económicas, brindan elementos críticos para comparar los beneficios y costos entre dos o más tecnologías, lo que a su vez permite generar políticas públicas en salud, planes de coberturas, protocolos de uso apropiados, y por supuesto, orientar las recomendaciones de guías de manejo clínico (132).

Una evaluación económica permite, entonces, identificar los factores determinantes del costo en salud, específicamente los costos directos médicos (133), en que incurrir tanto el sistema como el paciente, comparándolos entre las tecnologías a evaluar. Esta información se empalma con la efectividad comparativa de las tecnologías, algo que ya conocemos desde la medicina basada en la evidencia. Ya sea que se trate de evaluaciones de tipo costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio, o minimización de costos, se invoca el concepto de costo de oportunidad el cual se define como “los rendimientos que podrían haberse obtenido si un recurso concreto se hubiera utilizado en otro uso alternativo... [es decir] la aproximación a su medida suele hacerse de acuerdo con la cantidad de otros bienes o servicios que se sacrificarán por obtener unos resultados determinados” (131).

En el desarrollo de las recomendaciones, se identificaron aspectos de índole económico que pueden llegar a influir, positiva o negativamente, en la implementación de alguna de las recomendaciones. Por este motivo, se efectuó una revisión general de la literatura de evaluaciones económicas, con el fin de aportar elementos de juicio a los tomadores de decisión para el proceso de implementación de esta guía.

Se aclara que esta revisión no pretende sustituir los ejercicios de costo-efectividad y análisis presupuestal de los actores que fungen el rol de pagadores, sino que, por el contrario, busca señalar los elementos clave que determinan si una tecnología aporta una adecuada relación costo-beneficio.

Así mismo, no pretende ser exhaustiva. El objetivo es identificar los elementos de costo o beneficio que determinaron la conclusión del estudio seleccionado. Ex-

presado de otra forma, sabemos comparar los efectos de acuerdo con las medidas de asociación epidemiológicas y la estadística que las soporta, pero cuando adicionamos el componente del costo en la ecuación, se deben considerar los elementos que determinar el costo, principalmente, la frecuencia de uso y el precio de la tecnología.

5.1. COSTO-EFECTIVIDAD DEL PET-TC

Auguste y colaboradores publicaron en 2014 un análisis de costo-efectividad acerca del rol del PET-CT en el contexto de vigilancia rutinaria y seguimiento de pacientes con cáncer de cérvix (134). Para ello, los autores desarrollaron un modelo de Markov en el que se establecieron varios estados luego del tratamiento para cáncer primario: asintomático sin cáncer, asintomático con cáncer, sintomático sin cáncer, sintomático con cáncer, asintomático con recurrencia, sintomático con recurrencia, post-tratamiento, muerte.

Para los beneficios, los autores se apoyaron en una revisión de la literatura y consulta de expertos. Para los costos, recurrieron a los reportes de costos directos médicos del NHS (del inglés National Health Services) del Reino Unido, a valores de 2010. Se tomó la perspectiva del sistema de salud del Reino Unido. Se estimó una tasa de descuento anual del 3.5%.

Los autores construyeron 4 modelos de análisis a partir de 4 cohortes teóricas: 1) mujeres quienes ya han sido tratadas con cirugía para cáncer cervical en estadio temprano; 2) mujeres quienes, además de la cirugía, recibieron quimioterapia en adyuvancia para cáncer de cérvix temprano debido a factores de riesgo (márgenes positivos, tamaño, invasión estromal profunda, etc); 3) mujeres que han recibido qui-

mioterapia para cáncer temprano (estadios I y IIa) pero no cirugía; y 4) mujeres que han recibido quimiorradioterapia para cáncer avanzado (estadios IIb, III y IV), sin cirugía.

Los resultados fueron:

Para el modelo 1:

- El PET-CT incrementa en 0.0010 los Años de Vida ajustados a Calidad (AVAC) sobre el manejo estándar (4.1096 vs 4.1086).
- El PET-CT incrementa el costo en £ 9,588 (£ 18,757 vs £ 9,169).
- La razón de costo-efectividad incremental (ICER) fue de £ 9,254,000 por cada AVAC ganado.

Para el modelo 2:

- El PET-CT incrementa en 0.0080 los Años de Vida ajustados a Calidad (AVAC) sobre el manejo estándar (4.1581 vs 4.1501).
- El PET-CT incrementa el costo en £ 9,428 (£ 17,122 vs £ 7,695).
- La razón de costo-efectividad incremental (ICER) fue de £ 1,173,000 por cada AVAC ganado.

Para el modelo 3:

- El PET-CT incrementa en 0.0088 los Años de Vida ajustados a Calidad (AVAC) sobre el manejo estándar (4.1595 vs 4.1507).
- El PET-CT incrementa el costo en £ 9,419 (£ 17,031 vs £ 7,612).
- La razón de costo-efectividad incremental (ICER) fue de £ 1,065,000 por cada AVAC ganado.

Para el modelo 4:

- El PET-CT incrementa en 0.0080 los Años de Vida ajustados a Calidad (AVAC) sobre el manejo estándar (4.1581 vs 4.1501).
- El PET-CT incrementa el costo en £ 9,428 (£ 17,122 vs £ 7,695).
- La razón de costo-efectividad incremental (ICER) fue de £ 1,173,000 por cada AVAC ganado.

Con base en lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta que el umbral de costo-efectividad aceptado por el Reino Unido es de £ 20,000 – 30,000, se concluye que la intervención de adicionar PET-CT al manejo estándar no es costo-efectivo. Lo anterior implica que, de acuerdo con lo escrito por los autores de este estudio, el uso de PET-CT en el diagnóstico de recurrencia de cáncer de cérvix no es una estrategia costo-efectiva para el sistema de salud británico, y es se encuentra muy lejos del umbral de costo-efectividad establecido. Esto se debió principalmente por los altos costos del PET y por el pequeño beneficio adicional que aporta en AVAC frente a lo que ya aporta el manejo estándar.

Consideraciones para el contexto de la ciudad de Cali

Este estudio expone la situación en que se cuenta con una tecnología que es muy costosa, y que no parece que mejore en gran medida los beneficios que ya aporta del manejo estándar, para el caso en mención, los beneficios del TAC y/o de la RMN. De acuerdo con los datos presentados, el PET aporta milésimas de AVAC adicionales, y el costo de esta tecnología es elevado (el costo del PET se reportó en £ 744, en comparación con el costo de la RMN de £ 366 y de los £ 162 del TAC). En este orden de ideas, y

llevado esta evidencia al contexto de la ciudad de Cali, se requiere de estrategias que permitan identificar un grupo de pacientes que se pueden beneficiar mucho más del PET CT, de tal manera que la efectividad incremental sea mucho mayor. Esto puede realizarse a través de estudio epidemiológicos locales, o mediante consenso de actores para desarrollar instrumentos de identificación y estratificación del riesgo de aquellas mujeres que se pueden beneficiar, o no tanto, del uso de PET en el proceso diagnóstico y de seguimiento.

Por el lado del costo, las intervenciones encaminadas a regular las tarifas del PET en Cali pueden ser más complejas, pero las estrategias de uso apropiado y eficiente pueden generar algunos incentivos para

regular la frecuencia de uso a favor de ambas partes (EAPB como pagador, e IPS por proveedor), así como seguimiento de los entes de control que mitiguen fenómenos de oligopolio dado que se cuenta con pocos equipos en la ciudad.

Es importante mencionar que estudios como el expuesto, que pueden ser considerados negativos por no hallarse costo-efectividad, lo que realmente muestran es la incertidumbre significativa respecto a la utilización del PET CT. Por tanto, invitan a realizar evaluaciones a nivel local del comportamiento real de la efectividad y del costo (dado por la tarifa y la frecuencia de uso) para construir evidencia local, que brindará mejores herramientas para los tomadores de decisión de la ciudad de Cali.

6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

6.1. ASPECTOS GENERALES

Las guías de práctica clínica tienen como propósito fundamenta brindar ciertas pautas para el apoyo en la toma de decisiones clínicas, de tal forma que reduzca la variabilidad médica relacionada con atención de pobre calidad. En este sentido, representa una herramienta que buscar facilitar el acceso de la mejor evidencia disponible para afrontar los problemas clínicos del día a día de los equipos de salud, de tal manera que esto redunde en la atención óptima del paciente con cáncer. Para cumplir con este propósito, la presente guía debe implementarse por parte de todos aquellos actores que estén in-

volucrados en la atención de la población oncológica, sea de manera directa o indirecta.

Pero la implementación propiamente dicha es el paso final de un proceso. Este proceso consiste en cuatro momentos (135):

- **Adopción:** hace referencia a la decisión y compromiso de los actores para incorporar en su práctica cotidiana, sea clínica o administrativa, las recomendaciones contenidas dentro de la guía.
- **Difusión:** hace referencia a los procedimientos de distribución de la información que dan a conocer la guía y sus recomenda-

ciones. Este paso corresponde a actividades de divulgación pasiva mediante la entrega de copias del manuscrito ya sea físico o por medio digital, presentación de medios de comunicación y eventos de socialización con un alcance de presentación de la guía.

- **Diseminación:** hace referencia a un proceso activo, sistemático y organizado, encaminado a la ejecución de actividades tendientes a trasladar el conocimiento a los usuarios finales de la guía. A diferencia del paso de difusión, este corresponde a todas aquellas actividades de comunicación y educación orientadas a la comprensión y aprehensión de las recomendaciones de la guía.

- **Implementación:** corresponde a la puesta en marcha real de la guía, esto es, se traslada las recomendaciones “desde el papel” a la toma de decisiones en la “realidad del día a día”. Para lograr este paso, a parte de pasar por los anteriores, se requiere de la identificación y abordaje de potenciales barreras para la efectiva implementación de la guía.

Existe evidencia desde principios de la década de los 90 de que las guías de práctica clínica tienen el potencial de mejorar los desenlaces en salud (136). En 2001 Smith y Hillner publicaron un estudio sobre el impacto de las guías de práctica clínica en cáncer, encontrando que efectos positivos sobre la estancia hospitalaria, tasas de complicaciones y costos asociados (137). En este último estudio, comentar los autores los factores que asociaron con el éxito del efecto de las guías: desarrollo de guías basadas en la evidencia, guías diseminadas a todos los profesionales de salud involucrados, implementación que incluye retroalimentación directa en el desempeño del médico o retroalimentación general sobre el desempeño del sistema, y responsabilidad para actuar acorde a las guías por medio de incentivos (presión de pares).

Infortunadamente, existe una brecha importante entre la evidencia y la práctica, pues el mero hecho de que la guía (y por tanto la evidencia) esté disponible no implica que automáticamente la calidad en la atención mejorará, el denominado “abismo de la calidad”: la brecha entre la práctica actual frente a la atención óptima del paciente (138). De hecho, una publicación del 2017 evaluó el nivel de adherencia a guías de cáncer (139), encontrando que el promedio de adherencia varió entre 40% al 99%, y que dependía en algunos casos de guías específicas del grupo de riesgo (la adherencia a guías de cáncer de pulmón osciló entre 40% a 70%, mientras que la de cáncer de mama estuvo entre 90% a 100%) y en otros dependía de su alcance (mayor adherencia a la que se limitaron a manejo farmacológico vs guías con un mayor alcance, es decir, desde diagnóstico hasta tratamiento).

Grol publicó en 2003 un artículo en el que exponía algunos lineamientos para una implementación efectiva (140). Grol comenta que el cambio conductual hacia una adopción e implementación de las guías es posible, pero que tal cambio requiere de un abordaje en diferentes niveles (profesional, equipo de salud, institución, sistema de salud), y de un plan que depende tanto de la guía misma (su alcance) como de la identificación de barreras y facilitadores del cambio.

Con el fin de identificar actores clave, así como barreras potenciales para la implementación de la presente guía, se realizaron entrevistas grupales semiestructuradas con representantes de las Entidades Administradoras del Plan de Beneficios -EAPB-. Se decantó por este actor ya que, desde su perspectiva de aseguramiento, definido éste como “la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de servicios que garantice el acceso efectivo, la garantía de la calidad en

la prestación de servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador y los demás actores” (141), tiene la visión más allá de un prestador y es el que concentra y responde por la gestión integral del riesgo de la población con cáncer.

6.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

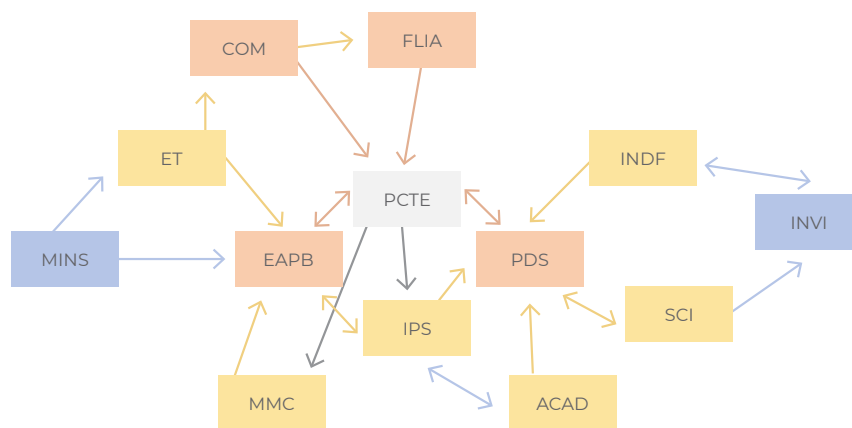
Con base en las entrevistas grupales, se identificaron actores que se consideran clave en el proceso de implementación de la guía, ya que están relacionados directa o indirectamente con la atención de los pacientes con cáncer. Estos actores son (organizados en orden alfabético):

- Comunidad
- El paciente
- Entidad territorial
- Entidades Administradoras del Plan de Beneficios -EAPB-

- Familia y red de apoyo al paciente
- Industria farmacéutica
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS-
- INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)
- La academia
- Medios de comunicación masiva
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Profesionales de la salud
- Sociedades científicas

Así mismo, se elaboró el siguiente mapa de actores que no busca ser exhaustivo, pero sí evidenciar aquellos actores con influencia directa sobre el paciente (rojos), aquellos con influencia indirecta (amarillos) y aquellos con un rol regulador sobre otros actores diferentes al paciente (azul).

Ilustración 1 Mapa de actores clave



FUENTE: Elaboración propia.

PCTE: paciente. EAPB: Entidad administradores del plan de beneficios. IPS: Institución prestadora de servicios de salud. PDS: profesionales de salud. ACAD: Academia. SCI: Sociedades científicas. INDI: industria farmacéutica. INVI: INVIMA. MMC: medio masivos de comunicación. FLIA: familia. COM: comunidad. ET: Entidad territorial. MINS: Ministerio de Salud.

Como actores del sistema de salud de la ciudad de Cali, tiene un papel sobre el proceso de implementación de la presente guía de práctica clínica. Una vez identificados, y de acuerdo con su rol sobre el paciente e influencia sobre el sistema, se proponen varias estrategias para vincular adecuadamente en los procesos de adopción, difusión, diseminación e implementación (142):

Monitoreo: Seguimiento o rastreo de las posiciones de los actores mediante investigación o discusión con otras partes.

Mensajes: Adaptar el alcance y la mensajería de las comunicaciones para satisfacer las expectativas de los actores, además de crear y dirigir mensajes a actores específicos.

Abogacía: Actividades para conseguir apoyo para un esfuerzo específico.

Consultoría: Solicitar comentarios o retroalimentación explícitos sobre el plan de implementación. Implica una expectativa por parte de los actores consultados de que la guía realizará cambios concretos con base en la consultoría efectuada.

Colaboración: Iniciar o participar en un diálogo bidireccional centrado en el aprendizaje mutuo y las soluciones. Puede incluir la creación conjunta de nuevas ideas y enfoques.

Innovación: Trabajo compartido sobre objetivos comunes de la guía y los actores. Puede incluir la co-creación, así como la co-implementación, de nuevas ideas.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS

Mediante entrevistas grupales realizadas entre septiembre y octubre de 2020 con representantes del equipo de gestión de riesgo en salud de las EAPB, se identificaron potenciales barreras en el proceso de atención del paciente con cáncer. Estas barreras se clasificaron de acuerdo con las categorías propuestas en la guía metodológica para la elaboración de guías del Ministerio de Salud (143). Sin embargo, dada la multiplicidad de tipos de barreras encontradas en el contenido discursivo de los representantes de las EAPB, se procedió a realizar una sub-categorización, la cual se describe a continuación:

CATEGORIA

SUB-CATEGORIA

Calidad de la guía	Ausencia de escalonamiento terapéutico
	Dificultades para el uso apropiado de la guía por parte de profesionales de salud no médicos.
	Desconocimiento en tiempos y frecuencias en el seguimiento
	Recomendaciones desactualizadas de las guías actuales.
Contexto organizacional	Deficiencias en los Canales de comunicación Paciente-EAPB-IPS
	Falta de Confianza entre EAPB-IPS
	Falta de Coordinación de la atención (navegación incompleta)

	Mal Funcionamiento de equipos y dispositivos que retrasan la atención (ej. Mal funcionamiento del resonador, o del acelerador lineal) Desconocimiento del Mecanismo de Puerta de entrada hacia la ruta oncológica Ausencia de un Prestador Integral Ineficiencias en el Proceso de autorizaciones y prestación no efectiva del servicio Fallas en la Red de prestadores: organización, articulación, integración servicios Mal Relacionamiento con el Ente Territorial Deficiencias en Sistemas de información
Contexto social	Cartera pendiente por la EAPB Falta de Gestión del No PBS: uso apropiado, uso de criterios de costo-efectividad Baja Oferta de servicios en salud especializados y sub-especializados Pagos prospectivos ausentes o no integrales Problemas en la Relación contractual IPS-EAPB Dificultades en el acceso de la población procedente de entorno rural
Individual profesional	Falta de Activación Temprana del Equipo de Cuidados Paliativos Falta de Adherencia a guías y protocolos Conocimiento escaso del sistema de salud en cuanto a rutas de atención, redes de prestadores Notas en historia clínica deficientes de información relevante Cambio inesperado de IPS de atención Variabilidad la práctica médica elevada Falta de formación y capacitación del RRHH de Atención Primaria para interpretación de tamizajes alterados y sospecha precoz de cáncer
Otros (categoría emergente)	Baja calidad y desempeño de las pruebas diagnósticas Carga de enfermedad elevada para la ciudad de Cali Uso inapropiado del sistema de clasificación CIE-10 Efectos adversos frecuentes que desincentivan a los pacientes de continuar el tratamiento. Ausencia de monitoreo de la cohorte de supervivientes asociado a incertidumbre de cuando finaliza el seguimiento por parte de la IPS Oncológica

	No priorización de población en riesgo alto
	Problemas jurídicos y operativos relacionados por reputación de la EAPB
	Falta de un programa estructurado por parte de la IPS oncológica que una atención más allá de la consulta
Paciente	Falta de adherencia o empoderamiento del paciente
	Complejidad elevada del caso relacionado con multimorbilidad o presentación atípica que retrasa el diagnóstico.
	Migración de domicilio recurrente que dificulta el seguimiento
	Mitos y creencias que pueden impedir el acceso temprano o la continuidad en le tratamiento
Proceso de implementación	Diseminación de guías deficiente
Tecnologías emergentes innovadoras	Falta de acuerdos en el uso de tecnologías recientes o costosas entre la IPS y la EAPB
	Rol del INVIMA poco claro en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, actualización de indicaciones terapéutica y socialización a sociedades científicas, profesionales de salud y EAPB del cabildeo de la industria farmacéutica.

6.4. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS O FACILITADORES PARA RESOLVER LAS BARRERAS

Con las barreras identificadas por los representantes de las EAPB, se procedió a formular posibles estrategias o facilitadores que puedan resolver tales barreras. Con el fin de analizar las diferentes propuestas, se procedió a generar categorías fundamentales teóricamente en los componentes de salud basada en valor de Michael Porter (144), junto con dos componentes del Modelo de Cuidados Crónicos (145). A continuación, se describen las propuestas de estrategias o facilitadores:

6.4.1. Equipo de salud multidisciplinario

- Aumentar la formación y capacitación en oncología por parte de los profesionales de auditoría clínica.
- Desarrollar consenso entre los profesionales de la salud en cuanto al uso de tecnologías en salud No PBS de alto costo, respecto a uso apropiado, indicaciones sustentadas en la evidencia, limitaciones en el uso, y resultados esperados. Esta propuesta busca evitar barreras por procesos de auditoría de pertinencia y reprocesos interinstitucionales.
- Diseñar formatos de guías y protocolos teniendo en cuenta el usuario objetivo, esto con el fin de visibilizar y estandarizar la práctica clínica de los profesionales de salud que participan en el cuidado del paciente con cáncer (ej: profesionales de enfermería, personal administrativo, entre otros)
- Generar incentivos para que los profesionales de la salud se apoyen en las diferentes Sociedades Científicas a través el uso del

formato UNIRS, con el fin de promover la inclusión de nuevas indicaciones INVIMA, o actualización de estas, por medicamentos de reciente incorporación al mercado colombiano, o con un nuevo uso terapéutico no contemplado por el INVIMA.

- Involucrar a los actores de la academia para la discusión, disseminación y construcción de las recomendaciones de las guías
- Promover el uso adecuado de la plataforma MIPRES en aspectos como dosis, cantidad según dosis, tiempo de tratamiento, indicación INVIMA vs indicación en la prescripción (algunas tecnologías son PBS según el diagnóstico).
- Promover la satisfacción del profesional de la salud mediante contratación directa, capacitaciones, espacios para retroalimentación entre pares y compañeros, entre otros mecanismos que fomenten la preparación y empoderamiento del equipo de salud.

6.4.2. Gestión del riesgo en cáncer

- Coordinar las actividades propias de la Entidad Territorial con los mecanismos de captación e identificación de pacientes por parte de la EAPB
- Generar sistemas de alerta temprana cuando surja una prueba de tamización alterada.
- Proponer sistemas de clasificación de riesgo administrativo, esto es, un sistema que permita priorizar y/o agilizar procesos administrativos de tal forma que activen una ruta diferencial ante ciertos pacientes que por su condición clínica o psico-social requieran de tiempos de atención acortados y que pueden impactar directamente en desenlaces en salud. Este sistema estaría diseñado tanto por la EAPB en conjunto con su Prestador Oncológico y Prestador Primario.

- Formar personal administrativo “experto” o “gestor centinela” que puede no ser profesional de salud, pero sí altamente capacitado y entrenado en los requerimientos de la ruta de atención.

6.4.3. Mecanismos de pago

- Buscar los medios para que los mecanismos de pago involucren la sospecha de cáncer y no sólo desde el diagnóstico por histopatología del cáncer. Esto podría incluir en el pago servicios de tamización y la patología.
- Considerar la posibilidad de que los pagos prospectivos incluyan viáticos y traslados, especialmente en lo referente a población pediátrica.
- Generar alternativas a los mecanismos de pago prospectivos globales en cáncer por mecanismos que cubran sólo un grupo de riesgo (por ej, un PGP únicamente para Ca mama)
- Incentivar la migración de mecanismos de pago por actividad a presupuestos globales prospectivos, u otros mecanismos de pago prospectivos, que apalanquen las rutas de atención y coordinen la red de prestadores.
- Para aquellas atenciones que, mediante mecanismos de pago por actividad o evento, se propone mejorar los tiempos de radicación de facturas por parte de la IPS, así como mejorar los tiempos de glosas y conciliaciones por parte de la EAPB, con el propósito de mitigar cualquier cadera potencial que pueda afectar directa o indirectamente la prestación de servicios oncológicos.

6.4.4. Monitoreo y seguimiento

- Establecer pautas de seguimiento en el paciente con cáncer de la manera más detallada y especificando las frecuencias/ intervalos de uso de tecnologías en salud, sean consultas, laboratorios, imágenes, con el propósito de fortalecer los equipos de seguimiento de cohortes (tanto desde la IPS como de la EPAB).
- Fortalecer los equipos encargado de la navegación del paciente oncológico, mediante la formación y capacitación del personal, así como con la disponibilidad de usar tecnologías informáticas que faciliten el proceso de captura, procesamiento y análisis de la información.
- Promover los sistemas de farmacovigilancia por parte de la EAPB y la IPS.
- Promover programas para el seguimiento de la cohorte de supervivientes, y acordar cuándo y cómo se daría alta por parte de oncología, y qué pautas debería seguir el Prestador Primario en este tipo de pacientes.

6.4.5. Paciente, familia y comunidad

- Activar e involucrar a la red de apoyo del paciente, grupo familiar y/o cuidadores sobre la importancia y significados de los Cuidados Paliativos
- Generar mecanismos de activación de la comunidad cercana al paciente con cáncer dirigidos a fomentar la identificación de signos de alarma, utilización de pruebas de tamización, asistencia a programas, y reconocimiento de su IPS primaria.

6.4.6. Plataformas de información

- Fomentar el uso de un sistema de infor-

mación común y unificado entre los actores del sistema de salud de la ciudad de Cali.

- Formar y capacitar al personal de salud respecto a las plataformas de información, su relevancia y dependencia de la historia clínica como fuente primaria de datos. Se incluiría socializar la importancia e impacto que tiene el uso de los CIE-10.

- Proponer un repositorio de biopsias de la ciudad de Cali, similar al registro poblacional de cáncer, con un sistema de clasificación consensuado.

- Utilizar Apps u otras plataformas de TIC para facilitar procesos de autorizaciones, gestión de citas, entre otros.

6.4.7. Redes integrales e integradas en salud

- Ante eventualidades que impidan la adecuada prestación de servicios en salud, socializar y mantener al corriente a toda la red de prestadores aliados a la EAPB para activar redireccionamiento o alternativas de prestador, en pro de la oportunidad y continuidad de la atención del paciente con cáncer.

- Articular de manera efectiva los programas de atención primaria, red de urgencias, red hospitalaria y red complementaria con la puerta de entrada al Prestador Oncológico.

- Considerando la importante carga de enfermedad (riesgo primario) del cáncer en la ciudad de Cali, se propone que las EAPB e IPS cuenten con el recurso humano necesario para operativizar las rutas, los acuerdos contractuales, los reportes de información, etc.

- Convocar a una mesa técnico-científica en la que participen las IPS, EAPB y Entidad Territorial, con el propósito de realizar un consenso de ciudad dirigido al uso escalonado de medicamentos de uso oncológico.
- Crear salas situacionales entre las IPS oncológicas con el fin de generar un espacio para la gestión del conocimiento en cáncer desde la perspectiva del prestador, esto es, unificar criterios clínicos de diagnóstico y tratamiento, así como esquemas de seguimiento, apoyados por las guías de práctica clínica de cada institución, así como guías complementarias (como el presente documento).
- Crear salas situaciones entre las EAPB con el fin de generar un espacio para gestión del conocimiento, esto es, unificar criterios de gestión del riesgo en cáncer, lecciones aprendidas de casos de pacientes complejos, estrategias exitosas, entre otros elementos. Esta estrategia puede estar mediada por el Ente Territorial, así como otras organizaciones (ej ACEMI).
- Desarrollar rutas de atención por parte de las EAPB que integren las necesidades en salud de la población con cáncer, acompañado de actividades de socialización y disseminación que permitan articular la red de prestadores en términos estructurales y funcionales, y dirigidas al cumplimiento de indicadores de red (no indicadores por IPS).
- Establecer un contrato entre la EAPB y la IPS de tal forma que sea detallado en los servicios pactados, el uso de plataformas de información, frecuencia y contenidos de información entre ambas partes, y que en su construcción se involucre los equipos táctico-operativos.
- Fomentar el desarrollo de tecnologías que contengan información clínica sensible y relevante por parte del paciente, que facilite la articulación entre los prestadores que le brindan la atención.
- Fortalecer los espacios entre la IPS y la EAPB para la discusión de casos, encaminado a lograr resultados en salud mediante el ajuste y/o corrección de procesos y planes de mejoramiento. En esta estrategia estaría contemplado comités de seguridad del paciente, hospitalización potencialmente evitable, mortalidad evitable, casos atípicos o de alto costo, entre otros.
- Generar herramientas de apoyen la toma de decisiones clínica, como son las vías clínicas, algoritmos de tratamiento, protocolos, y demás elementos que disminuyan la variabilidad de la práctica médica. Esto podría ser la materialización de un estándar de ciudad y que evita cambios en el manejo si el paciente migra a otra IPS para su atención.
- Generar los canales de comunicación y equipos articuladores entre la alianza IPS-EAPB en el marco de generación/modificación contractual, de tal forma que el recurso humano involucrado en todos los procesos reconozca su par en la otra institución y su apoyo administrativo.

6.4.8. Unidad de práctica integrada en cáncer

- Crear mesas a nivel municipal o departamental en el que se realicen consensos respecto a la incorporación de una tecnología emergente o recién llegada al mercado, y que se articule con una dependencia del INVIMA (similar al proceso de ingreso de biosimilares).

- Desarrollar la post-consulta como mecanismo de validación tanto de puerta de entrada a ruta oncológica como de activación del paciente y red de apoyo.
- Explorar la inclusión en las guías la heterogeneidad o variabilidad esperada de los pacientes, ya que no todos siguen un mismo curso de enfermedad.
- Explorar la resolutiveidad esperada y alcance de especialidades frente a la demanda de sub-especialidades, con el fin de encontrar un equilibrio entre las necesidades de los pacientes y la capacidad instalada de la ciudad de Cali.
- Fortalecer los programas de atención domiciliar para garantizar el acceso a pacientes que residen en la periferia/zona rural de la ciudad de Cali
- Garantizar por parte de la EAPB los canales de comunicación para resolver dudas o inquietudes administrativas, y por parte de la IPS en cuanto a asignación de citas, es especial si el paciente requiere de múltiples servicios ofertados por el mismo prestador (ej, control con oncología, con cirugía oncológica, y con cuidados paliativos)
- Generar actualizaciones frecuentes de las guías para los grupos de riesgo priorizados.
- Generar los incentivos necesarios para la transformación de las IPS oncológicas en UFCA y UACAI.
- Para optimizar el recurso, se propone establecer acuerdos para agotar en primera instancia los medicamentos PBS, teniendo en cuenta aspectos de costo-efectividad.
- Realizar guías focalizadas en el uso apropiado de medicamentos especificados, ya sea por su alto volumen y/o su alto costo.

7. PLAN DE ACTUALIZACIÓN

De acuerdo con lo establecido el manual metodológico del Ministerio de Salud y Protección Social, se recomienda realizar una revisión y actualización de esta guía dentro de 3 años, o antes, de acuerdo con la disponibilidad de nueva evidencia que pueda cambiar la fuerza o dirección de las recomendaciones. De igual manera, se sugiere el establecimiento de un grupo técnico encargado del monitoreo regular de las guías desarrolladas

en el marco del proyecto C/Can, con el fin de que frecuentemente exploren las publicaciones de estudios relevantes con resultados interinos, estudio finalizados posterior a la publicación de esta guía, desarrollo de nuevas guías o sus actualizaciones de las ya existentes tanto por instituciones nacionales como internacionales, o que identifique por parte de los expertos de la ciudad la necesidad de incorporar nueva evidencia.

ANEXOS

ANEXO 01. CONFLICTO DE INTERESES

Todos los miembros del grupo desarrollador, así como los colaboradores, realizaron una declaración de conflicto de intereses antes o durante las sesiones para la elaboración de las recomendaciones. Cada una de estas declaraciones fue debidamente registrada y analizada.

A continuación, se reporta la declaración de conflicto de interés por cada uno de los participantes de la guía.

NOMBRE	ESPECIALIDAD / FORMACIÓN	PRESENCIA DE INTERÉS
Liliana María Yepes	Ginecóloga Oncóloga	SI ☐ NO ☒

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Interés económico personal | ☐ C. Interés No económico personal |
| ☐ B. Interés económico No personal | ☐ D. Interés económico personal de un familiar |

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA

- ☒
- Participa
- ☐
- Limitación Parcial
- ☐
- Exclusión

ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO

Ninguno

NOMBRE	ESPECIALIDAD / FORMACIÓN	PRESENCIA DE INTERÉS
Javier Burbano	Ginecólogo Oncólogo	SI ☐ NO ☒

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

- | | |
|--|--|
| ☐ A. Interés económico personal | ☐ C. Interés No económico personal |
| ☐ B. Interés económico No personal | ☐ D. Interés económico personal de un familiar |

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA

- ☒
- Participa
- ☐
- Limitación Parcial
- ☐
- Exclusión

ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO

Ninguno

NOMBRE

Ángela Zambrano

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Oncóloga Clínica

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☒ NO ☐**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**☒ A. Interés económico personal☐ C. Interés No económico personal☐ B. Interés económico No personal☐ D. Interés económico personal de un familiar*Roche Congreso de cancer gastro intestinal enero de 2020.**Lily - julio 2020, Bristol Myers Squibb junio -2020, Roche Mayo 2020, MSD julio 2020***PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa☐ Limitación Parcial☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Iván Ríos Hernández

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Oncólogo Radioterápico

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**☐ A. Interés económico personal☐ C. Interés No económico personal☐ B. Interés económico No personal☐ D. Interés económico personal de un familiar**PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa☐ Limitación Parcial☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Elsa Cuervo Madrid

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Oncóloga Radioterápica

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**☐ A. Interés económico personal☐ C. Interés No económico personal☐ B. Interés económico No personal☐ D. Interés económico personal de un familiar**PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa☐ Limitación Parcial☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

José Tobías Fuentes

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Oncólogo Radioterápico

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**☐ A. Interés económico personal☐ C. Interés No económico personal☐ B. Interés económico No personal☐ D. Interés económico personal de un familiar**PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa☐ Limitación Parcial☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

María Mercedes Fajardo

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Anestesióloga, Esp en Dolor y Cuidado Paliativo

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

María Ximena Varela

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Patóloga

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

María Claudia Moreno

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Patóloga

PRESENCIA DE INTERÉSSI ☒ NO ☐**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☒ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
- ☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

*Financiado por ROCHE.**Advisory Board – Patología en el Cáncer de Ovario
Septiembre 20 de 2019. Bogotá-Colombia. Financiado por Astra Zeneca.**Participación en el Global Expert Meeting Foundation Medicine 2019. Munich Alemania
Noviembre 16 y 17 de 2019. Financiado por ROCHE.**PD-L1 Testing (22C3) Professional Expert Course Cross Histology CPS Training (CHCT)-Advanced Training
Octubre 30 y 31 de 2019. Bogotá-Colombia. Financiado por MSD.***PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Oscar Ramírez

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Pediatra Oncohematólogo

**PRESENCIA
DE INTERÉS**SI ☐ NO ☒**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☐ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

NOMBRE

Francisco Escobar Aguilón

ESPECIALIDAD / FORMACIÓN

Médico, candidato a Magíster en Salud Pública

**PRESENCIA
DE INTERÉS**SI ☒ NO ☐**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS**

- ☒ A. Interés económico personal ☐ C. Interés No económico personal
☐ B. Interés económico No personal ☐ D. Interés económico personal de un familiar

*Empleado como consultor para una compañía de salud.**Previa vinculación a dos EPS en las cuales una de las funciones estaba relacionada con la gestión del riesgo en cáncer.***PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA GUÍA**☒ Participa ☐ Limitación Parcial ☐ Exclusión**ASPECTOS EN LOS QUE ESTARÁ LIMITADO**

Ninguno

ANEXO 02. AGREE II

FECHA DE REVISION
NOMBRE DE LA GUIA

Octubre de 2020
Management and Care of Women With Invasive Cervical Cancer: American Society of Clinical Oncology Resource-Stratified Clinical Practice Guideline

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Journal of Global Oncology 2016;2(5)

TOTAL EVALUADORES

1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
		FRANCISCO ESCOBAR				
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7				7
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	2				2
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7				7
	Puntaje x Evaluador	16	0	0	0	16
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	72%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	2				2
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	2				2
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	6				6
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	2				2
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6				6
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	6				6
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	4				4
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	4				4
	Puntaje x Evaluador	32	0	0	0	32
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	50%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7				7
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7				7
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	5				5
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7				7
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7				7
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	5				5
	Puntaje x Evaluador	24	0	0	0	24
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	83%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7				7
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	6				6
	Puntaje x Evaluador	13	0	0	0	13
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	92%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	6				6
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	83%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios	La guía es muy completa y ofrece pautas para escenarios con recursos limitados. Sin embargo, debe verificarse en un momneto posterior el apartado de metodología ya que no está disponible para verificarse.				

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	72%
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	50%
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
Dominio 5 - APLICABILIDAD	83%
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	92%
CALIDAD GLOBAL	83%

TOTAL EVALUADORES

1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
		FRANCISCO ESCOBAR				
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 3. La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7				7
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	6				6
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7				7
	Puntaje x Evaluador	20	0	0	0	20
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	94%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7				7
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7				7
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7				7
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7				7
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6				6
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	6				6
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7				7
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	4				4
	Puntaje x Evaluador	51	0	0	0	51
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	90%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7				7
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7				7
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	3				3
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	3				3
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	6				6
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	7				7
	Puntaje x Evaluador	19	0	0	0	19
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	63%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7				7
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7				7
	Puntaje x Evaluador	14	0	0	0	14
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	7				7
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	100%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	94%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	90%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	63%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	100%

TOTAL EVALUADORES	2
-------------------	---

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x ítem
		Francisco Escobar	Iván Ríos Hernández			
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Ítem 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	6	7			13
	Ítem 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Ítem 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	20	21	0	0	41
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	97%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Ítem 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	1			8
	Ítem 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	2	5			7
	Ítem 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	6	7			13
	Puntaje x Evaluador	15	13	0	0	28
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	61%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Ítem 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	4	4			8
	Ítem 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	4	1			5
	Ítem 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	6	1			7
	Ítem 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	6	6			12
	Ítem 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6	6			12
	Ítem 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7	7			14
	Ítem 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	6	5			11
	Ítem 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	4	5			9
	Puntaje x Evaluador	43	35	0	0	78
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	65%				
	Ítem 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7			14
	Ítem 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	6	7			13
	Ítem 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	20	21	0	0	41
Dominio 5 - APLICABILIDAD	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	97%				
	Ítem 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	4	1			5
	Ítem 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	2	1			3
	Ítem 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	1	1			2
	Ítem 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	1	1			2
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Puntaje x Evaluador	8	4	0	0	12
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	8%				
	Ítem 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	6			13
	Ítem 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	6	7			13
	Puntaje x Evaluador	13	13	0	0	26
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	92%				
	Puntúe la calidad global de la guía.	5	6			11
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	75%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones		X			
	NO					
	Comentarios		Presenta la evidencia claramente y práctica, pero parece una guía independiente hecha por y para un grupo o población, no universal.			

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	97%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	61%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	65%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	97%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	8%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	92%
	CALIDAD GLOBAL	75%

FECHA DE REVISION: Octubre de 2020
 NOMBRE DE LA GUIA: Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Cérvicouterino. México: Secretaría de Salud, 2010
 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: ENLACE: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/433_GPC_Ca_cervicouterino/GER_Oncer_cervicouterino.pdf

TOTAL EVALUADORES: 2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1 Francisco Escobar	EVALUADOR 2 JUAN CARLOS ROJAS MONTENEGRO	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x ítem
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	6			13
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	5			12
	Puntaje x Evaluador	21	18	0	0	39
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	92%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	4			11
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	2	5			7
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7	6			13
	Puntaje x Evaluador	16	15	0	0	31
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	69%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7	6			13
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7	6			13
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7	5			12
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	7	6			13
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6	5			11
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	5	6			11
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	7	5			12
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	3	2			5
	Puntaje x Evaluador	49	41	0	0	90
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	77%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	7			14
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	6			13
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	6			13
	Puntaje x Evaluador	21	19	0	0	40
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	94%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	1	2			3
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	3	6			9
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	1	2			3
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	1	1			2
	Puntaje x Evaluador	6	11	0	0	17
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	19%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	6			13
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	6			13
	Puntaje x Evaluador	14	12	0	0	26
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	92%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	5	6			11
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	75%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones		X			
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	92%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERÉS	69%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	77%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	94%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	19%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	92%
	CALIDAD GLOBAL	75%

FECHA DE REVISION Octubre de 2020

NOMBRE DE LA GUIA Japan Society of Gynecologic Oncology guidelines 2017 for the treatment of uterine cervical cancer

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA International Journal of Clinical Oncology <https://doi.org/10.1007/s10147-018-1351-y>

TOTAL EVALUADORES	1
-------------------	---

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Ítem
		Francisco Escobar				
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7				7
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	7				7
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7				7
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	7				7
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	7				7
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	6				6
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6				6
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	6				6
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	6				6
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	4				4
	Puntaje x Evaluador	49	0	0	0	49
PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	85%					
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7				7
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7				7
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	1				1
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	4				4
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	2				2
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	1				1
	Puntaje x Evaluador	8	0	0	0	8
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	17%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7				7
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7				7
	Puntaje x Evaluador	14	0	0	0	14
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	6				6
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	83%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	100%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	85%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	100%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	17%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	83%

FECHA DE REVISIÓN: Octubre de 2020
 NOMBRE DE LA GUÍA: Practice guidelines for management of cervical cancer in Korea: a Korean Society of Gynecologic Oncology Consensus Statement
 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: J Gynecol Oncol. 2017 May;28(3):e22. <https://doi.org/10.3802/jgo.2017.28.e22>

TOTAL EVALUADORES: 1

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALLADOR 1	EVALLADOR 2	EVALLADOR 3	EVALLADOR 4	Puntaje x Item
		Francisco Escobar				
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7				7
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7				7
	Puntaje x Evaluador	21	0	0	0	21
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 1 EVALUADORES	100%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7				7
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	2				2
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	7				7
	Puntaje x Evaluador	16	0	0	0	16
PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 1 EVALUADORES	72%					
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	7				7
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	5				5
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	6				6
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	6				6
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6				6
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	7				7
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	6				6
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	4				4
	Puntaje x Evaluador	47	0	0	0	47
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 1 EVALUADORES	81%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7				7
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	6				6
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7				7
	Puntaje x Evaluador	20	0	0	0	20
PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 1 EVALUADORES	94%					
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	1				1
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	4				4
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	1				1
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoría.	1				1
	Puntaje x Evaluador	7	0	0	0	7
PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 1 EVALUADORES	13%					
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7				7
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7				7
	Puntaje x Evaluador	14	0	0	0	14
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 1 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	6				6
	PUNTAJE PARA 1 EVALUADORES	83%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones					
	NO					
	Comentarios	La guía ofrece una referencia muy actualizada de recomendaciones en el contexto de Ca de mama temprano, pero dado que tiene un rigor metodológico de calidad intermedia, es conveniente verificar la evidencia que sustenta las recomendaciones.				

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS	Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	100%
	Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	72%
	Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	81%
	Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	94%
	Dominio 5 - APLICABILIDAD	13%
	Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
	CALIDAD GLOBAL	83%

TOTAL EVALUADORES

2

DOMINIOS	PREGUNTAS	EVALUADOR 1	EVALUADOR 2	EVALUADOR 3	EVALUADOR 4	Puntaje x Item
		Francisco Escobar	ANGELA ZAMBRANO HARVEY			
Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	Item 1. El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente descrito(s).	6	6			12
	Item 2. El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) específicamente descrito(s).	7	7			14
	Item 3. La población (pacientes, público, etc) a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita.	7	4			11
	Puntaje x Evaluador	20	17	0	0	37
	PUNTAJE DOMINIO 1 PARA 2 EVALUADORES	86%				
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	Item 4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes.	7	7			14
	Item 5. Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, público, etc.).	2	7			9
	Item 6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos.	6	7			13
	Puntaje x Evaluador	15	21	0	0	36
	PUNTAJE DOMINIO 2 PARA 2 EVALUADORES	83%				
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	Item 7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia.	5	7			12
	Item 8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad.	5	7			12
	Item 9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas.	6	7			13
	Item 10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos.	6	7			13
	Item 11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos.	6	7			13
	Item 12. Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan.	6	7			13
	Item 13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación.	4	3			7
	Item 14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía.	5	7			12
	Puntaje x Evaluador	43	52	0	0	95
	PUNTAJE DOMINIO 3 PARA 2 EVALUADORES	82%				
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	Item 15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas.	7	6			13
	Item 16. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud se presentan claramente.	7	7			14
	Item 17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	21	20	0	0	41
	PUNTAJE DOMINIO 4 PARA 2 EVALUADORES	97%				
Dominio 5 - APLICABILIDAD	Item 18. La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación.	4	7			11
	Item 19. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica.	7	7			14
	Item 20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las recomendaciones, sobre los recursos.	7	3			10
	Item 21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria.	1	7			8
	Puntaje x Evaluador	19	24	0	0	43
	PUNTAJE DOMINIO 5 PARA 2 EVALUADORES	73%				
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	Item 22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influenciado el contenido de la guía.	7	7			14
	Item 23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo elaborador de la guía.	7	7			14
	Puntaje x Evaluador	14	14	0	0	28
	PUNTAJE DOMINIO 6 PARA 2 EVALUADORES	100%				
EVALUACIÓN GLOBAL DE LA GUÍA	Puntúe la calidad global de la guía.	6	7			13
	PUNTAJE PARA 2 EVALUADORES	92%				
	¿Recomendaría esta guía para su uso?					
	SÍ	X				
	SÍ, con modificaciones		X			
	NO					
	Comentarios					

RESUMEN PUNTAJE DE DOMINIOS

Dominio 1 - ALCANCE Y OBJETIVO	86%
Dominio 2 - PARTICIPACIÓN DE LOS IMPLICADOS O GRUPOS DE INTERES	83%
Dominio 3 - RIGOR EN LA ELABORACIÓN	82%
Dominio 4 - CLARIDAD DE PRESENTACIÓN	97%
Dominio 5 - APLICABILIDAD	73%
Dominio 6 - INDEPENDENCIA EDITORIAL	100%
CALIDAD GLOBAL	92%

ANEXO 03. REVISIÓN DE PARES EXTERNOS

Como parte del proceso de validación de calidad de la guía, la presente guía fue evaluada por pares externos expertos temáticos, tanto nacionales como internacionales, de manera independiente del grupo desarrollador multidisciplinario, con el fin de que brindaran aportes, comentarios y sugerencias respecto a las recomendaciones desarrolladas.

Para sintetizar las observaciones de los pares externos, así como el registro de los resultados de la evaluación de la opinión, se utilizó la siguiente herramienta adaptada de la guía metodológica del Ministerio de Salud y Protección Social:

Tabla 8 Herramienta de agregación y calificación de opiniones por los Pares Externos

No	Institución a la que representa	Opinión	Categoría de la opinión*	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión**	Resultado de la evaluación de la opinión***

* Edición, aclaración de términos, aporte, comentario positivo, comentario negativo-

** Sección, página de la guía.

*** Incluida, No Incluida.

No. 1 **Institución a la que representa**
American Society of Clinical Oncology

Opinión

La ASCO hizo especial énfasis en que no se considere a Cali como un escenario de recursos limitados, considerando que la tecnología se encuentra disponible. Como ejemplo, se comentó la restricción que había sobre el PET TC, que se dispone en la ciudad y que debe estar al alcance de los pacientes con Cáncer de Cérvix.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 2 **Institución a la que representa**
American Society of Clinical Oncology

Opinión

La ASCO sugirió que se revisara las indicaciones de vaciamiento ganglionar por parte del grupo de expertos quirúrgicos (ginecología oncológica) pues consideraron que estaban muy restringidas a un grupo mínimo de pacientes, lo que puede generar barreras de acceso.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 3 **Institución a la que representa**
American Society of Clinical Oncology

Opinión

La ASCO mencionó la importancia de contar con un grupo de seguimiento y navegación de los pacientes con cáncer de cérvix, para evitar demorar de diagnóstico y de inicio de tratamiento.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 4 **Institución a la que representa**
American Society of Clinical Oncology

Opinión

La ASCO recomienda la inclusión de recomendaciones acerca de Cuidados Paliativos y el rol de Enfermería Oncológica, como parte del equipo multidisciplinario encargado de la atención integral del paciente con cáncer de cérvix.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 5 **Institución a la que representa**
American Society of Clinical Oncology

Opinión

La ASCO comentar sobre la importancia de un seguimiento estricto al cumplimiento de las sesiones de radioterapia, hasta su culminación, la cual es fundamental para el pronóstico del paciente, inclusive más que la quimioterapia.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 6 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Sugieren desde el INC replantear el documento para que quede como una guía de manejo y no cómo una guía de práctica clínica. Las diferencias principales radican en que en la primera no hay una revisión sistemática de la literatura y se pasa a un segundo plano el seguimiento estricto de la metodología GRADE, lo que le permite ser más adaptable y flexible como documento, y puede ajustarse en el camino.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 7 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Sugieren la incorporación de la descripción de un Programa de atención, que permita llevar al contexto las recomendaciones ya trabajadas a un contexto más operativo, el que se incluyan aspectos de ruta, puerta de entrada, actividades clave, uso de herramientas de auditoría (lista de chequeo), mención de tiempos, modo en que se articulan los actores, rol de la APS, entre otros.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 8 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Sugieren que, si bien no se utilizó la metodología GRADE de manera estricta, se puede parafrasear las recomendaciones en “se recomienda” o “se sugiere” para dar a entender al usuario de la guía que ese lenguaje propio del GRADE (fuerza de la recomendación).

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 9 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Escribir un apartado, en la contraportada, de que el documento no es de obligatorio cumplimiento. Esto por motivo de que no son elementos de litigio en caso de procesos judiciales civiles o penales.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

No. 10 **Institución a la que representa**
Instituto Nacional de Cancerología

Opinión

Se sugiere que, si se va a hacer un proceso de adopción, se debe solicitar (y comprar) derechos de autor. Por ello, recomiendan que se haga una adaptación con modificaciones en las que no se incurra en plagio; eso aplica para tablas o gráficas, además del texto de las recomendaciones.

Categoría de la opinión	Apartado de la GPC a la pertenece la opinión	Resultado de la evaluación de la opinión
Aporte	Metodología	Incluida

ANEXO 04. CONSENSO DE EXPERTOS

BLOQUE TEMÁTICO	N	Completamente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Completamente de acuerdo	Completamente de acuerdo
Diagnóstico	1	0%	0%	0%	50%	50%	Acuerdo
Diagnóstico	2	0%	0%	0%	50%	50%	Acuerdo
Estadificación	3	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Estadificación	4	0%	0%	0%	25%	75%	Acuerdo
Estadificación	5	0%	25%	0%	0%	75%	Acuerdo
Estadificación	6	0%	0%	75%	0%	25%	No Consenso
Estadificación	7	0%	0%	0%	33%	67%	Acuerdo
Estadificación	8	0%	0%	67%	33%	0%	No Consenso
Clasificación Histopatológica	9	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Clasificación Histopatológica	10	0%	0%	0%	20%	80%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	11	0%	0%	0%	25%	75%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	12	0%	0%	0%	33%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	13	0%	0%	0%	67%	33%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	14	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	15	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	16	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IA1	17	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IA2	18	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IA2	19	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IA2	20	0%	0%	0%	33%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IA2	21	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB1	22	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IB1	23	33%	0%	33%	0%	33%	No Consenso
Tto: Estadio IB1	24	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo

Tto: Estadio IB1	25	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IB1	26	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB2 y IIA1	27	0%	0%	0%	33%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB2 y IIA1	28	0%	0%	0%	33%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB2 y IIA1	29	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IB2 y IIA1	30	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IB2 y IIA1	31	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB2 y IIA1	32	0%	0%	0%	33%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB3 y IIA2	33	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Tto: Estadio IB3 y IIA2	34	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IIB a IIIA	35	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IIB a IIIA	36	0%	0%	25%	25%	50%	Acuerdo
Tto: Estadio IIIB a IVA	37	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IIIB a IVA	38	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IIIB a IVA	39	0%	0%	25%	50%	25%	Acuerdo
Tto: Estadio IVB	40	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IVB	41	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Estadio IVB	42	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Tto: Enfermedad recurrente	43	0%	0%	0%	25%	75%	Acuerdo
Tto: Enfermedad recurrente	44	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Quimioterapia	45	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Quimioterapia	46	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Quimioterapia	47	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Quimioterapia	48	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Radioterapia	49	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Radioterapia	50	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Radioterapia	51	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Radioterapia	52	0%	0%	33%	0%	67%	Acuerdo
Radioterapia	53	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo

Radioterapia	54	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Seguimiento	55	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Seguimiento	56	0%	0%	25%	0%	75%	Acuerdo
Seguimiento	57	0%	0%	0%	0%	100%	Acuerdo
Seguimiento	58	0%	25%	25%	0%	50%	No Consenso

Posteriormente, se hizo una consulta al panel de expertos en relación con las 4 recomendaciones que no alcanzaron consenso, para ajustes y modificaciones para luego ser incluidas en la guía:

Bloque Temático	N	Recomendación original	Comentarios de los expertos	Observaciones para ajuste
Estadificación	6	Se sugiere la realización de PET/CT para el estudio del compromiso tisular a distancia, siempre y cuando las imágenes de TAC o RMN demuestren compromiso. Del mismo modo, es el método de elección para la planeación del tratamiento radioterápico con intención curativa.	* En caso de no ser evidenciado en TAC O RMN. * El PET no debería ser condicionado a los resultados del TAC o la resonancia	Se debe realizar TAC y/o RMN en caso de no contar con PET. Se ajusta.
Estadificación	8	Se recomienda realizar una radiografía de tórax, ecografía renal si hay sospecha de hidronefrosis, TAC o RM para determinar presencia de enfermedad a distancia.	* Es lo que se recomienda en paciente con carcinoma invasivo * Rx de tórax solo en casos sin afectación adenopática. La evaluación a distancia, con PET, si no TAC o RM.	De acuerdo, es lo que se debe manejar para determinar la estadificación. Se ajusta.
Tto: Estadio IB1	23	Para tumores de bajo riesgo estadio IB1, se sugiere la realización de histerectomía radical modificada + PLND, o de histerectomía radical modificada (HRM) + RT adyuvante, o HRM + RT pélvica + quimioterapia en dosis bajas.	* Depende de hallazgos en patología la elección de la adyuvancia	No requiere como condición la patología, por lo que se deja igual.
Seguimiento	58	Se sugiere realizar PET/CT en aquellas pacientes en quienes se les ha realizado tratamiento completo radical, con estadio FIGO IB2 o superior, para determinar o descartar presencia de enfermedad metastásica. También en pacientes que requerirían RT adyuvante o Quimiorradioterapia concomitante por factores de riesgo (adenopatías positivas, parametrio afectado, márgenes positivos) para descartar metástasis a distancia.	No hubo observaciones.	En total acuerdo, es el método de elección para estadificación es el PET/CT. Se deja igual.

REFERENCIAS

1. Cobiac LJ, Scarborough P. Translating the WHO 25x25 goals into a UK context: The PROMISE modelling study. *BMJ Open*. 2017;7(4):1-13.
2. Kim HS. Book Review: Primary, secondary, and tertiary prevention of cervical cancer. *J Gynecol Oncol*. 2014;25(2):157-8.
3. Jacobsen PB, Andrykowski M a. Tertiary Prevention in Cancer Care. *Am Psychol*. 2015;70(2):134-45.
4. Bravo LE, Arboleda OI, Ramirez O, Durán A, Lesmes MC, Rendler-García M, et al. Cali, Colombia, C/Can 2025 aprendizaje clave: desafío de ciudades contra el cáncer. *Colomb Med*. 2017;48(2):39-40.
5. Payer LJ. IARC: An environmental approach to cancer research. *Science* (80-). 1972;178(4063):844-6.
6. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2018 Nov;68(6):394-424.
7. Bravo LE, Muñoz N. Epidemiology of cancer in Colombia. *Colomb Med*. 2018;49(1):09-12.
8. Instituto Nacional de Cancerología. Anuario Estadístico 2016 [Internet]. Bogotá DC: Instituto Nacional de Cancerología; 2019. p. 1-132. Available from: [https://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/Anuario INC 2016](https://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/Anuario_INC_2016)
9. Mustafa M, Ajaz NA, Sharifa AM, Suleiman M, Yanggau B. Risk Factors for Cervical Cancer: Diagnosis and Management. *IOSR J Dent Med Sci*. 2016;15(6):104-10.
10. Momenimovahed Z, Salehiniya H. Incidence, mortality and risk factors of cervical cancer in the world. *Biomed Res Ther*. 2017;4(12):1795-811.
11. Bosch FX, Lorincz A, Muñoz N, Meijer CJLM, Shah K V. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. *J Clin Pathol*. 2002;55(4):244-65.
12. Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, Sankaranarayanan R. Cancer of the cervix uteri. *Int J Gynecol Obstet*. 2018;143:22-36.
13. Ibeanu OA. Molecular pathogenesis of cervical cancer. *Cancer Biol Ther*. 2011;11(3):295-306.
14. Köse FM, Naki MM. Cervical premalignant lesions and their management. *J Turkish Ger Gynecol Assoc*. 2014;15(2):109-21.
15. Martingano D, Renson A, Martingano AJ, Martingano FX. Variations in progression and regression of precancerous lesions of the uterine cervix on cytology testing among women of different races. *J Am Osteopath Assoc*. 2018;118(1):8-18.
16. Sankaranarayanan R, Joshi S, Muwonge R, Esmy PO, Basu P, Prabhu P, et al. Can a single dose of human papillomavirus (HPV) vaccine prevent cervical cancer? Early findings from an Indian study. *Vaccine*. 2018;36(32):4783-91.
17. Kreimer AR, Herrero R, Sampson JN, Porras C, Lowy DR, Schiller JT, et al. Evidence for single-dose protection by the bivalent HPV vaccine—Review of the Costa Rica HPV vaccine trial and future research studies. *Vaccine*. 2018;36(32):4774-82.
18. Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, Bryant A, Martin-Hirsch PPL, Mustafa RA, et al. Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in the general population. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(8).
19. Khan MJ, Smith-McCune KK. Treatment of cervical precancers: Back to basics. *Obstet Gynecol*. 2014;123(6):1339-43.
20. Cohen PA, Brand A, Sykes P, Wrede DCH, McNally O, Eva L, et al. Excisional treatment in women with cervical adenocarcinoma in situ (AIS): A prospective randomised controlled non-inferiority trial to compare AIS persistence/recurrence after loop electrosurgical excision procedure with cold knife cone biopsy: Protocol f. *BMJ Open*. 2017;7(e017576):1-9.
21. Kim M La, Hahn HS, Lim KT, Lee KH, Kim HS, Hong SR, et al. The safety of conization in the management of adenocarcinoma in situ of the uterine cervix. *J Gynecol Oncol*. 2011;22(1):25-31.
22. Karube A, Saito F, Nakamura E, Shitara A, Ono N, Konno M, et al. Reduction in HPV 16/18 prevalence among young women following HPV vaccine introduction in a highly vaccinated district, Japan, 2008-2017. *J Rural Med*. 2019;14(1):48-57.

23. Wong LP, Alias H, Yusoff RNARM, Sam IC, Zimet GD. Are Boys Ready for Human Papillomavirus Vaccine? A National Study of Boys in Malaysia. *Sex Transm Dis.* 2019;46(9):617–24.
24. Kellogg C, Shu J, Arroyo A, Dinh NT, Wade N, Sanchez E, et al. A significant portion of college students are not aware of HPV disease and HPV vaccine recommendations. *Hum Vaccines Immunother.* 2019;15(7–8):1760–6.
25. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, Denny LA, Grenman S, Karunaratne K, et al. Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri. *Int J Gynecol Obstet.* 2019;145(1):129–35.
26. Friberg S, Nystrom A. Cancer Metastases: Early Dissemination and Late Recurrences. *Cancer Growth Metastasis.* 2015;8:CGM.S31244.
27. Lee SH, Cho KJ, Ko MH, Cho HY, Lee KB, Lim S. Factors associated with parametrial involvement in patients with stage IB1 cervical cancer: Who is suitable for less radical surgery? *Obstet Gynecol Sci.* 2018;61(1):88–94.
28. Bermudez A, Bhatla N, Leung E. Cancer of the cervix uteri. *Int J Gynecol Obstet.* 2015;131:S88–95.
29. Kim K, Cho SY, Kim BJ, Kim MH, Choi SC, Ryu SY. The type of metastasis is a prognostic factor in disseminated cervical cancer. *J Gynecol Oncol.* 2010;21(3):186–90.
30. Paño B, Sebastiá C, Ripoll E, Paredes P, Salvador R, Buñesch L, et al. Pathways of Lymphatic Spread in Gynecologic Malignancies. *RadioGraphics.* 2015;35(3):916–45.
31. Viorel Scripcariu NI. Role of Sentinel Lymph Node in Early Stage of Uterine Cervical Cancer. *J Chir.* 2014;10(3).
32. Ki EY, Lee KH, Park JS, Hur SY. A clinicopathological review of pulmonary metastasis from uterine cervical cancer. *Cancer Res Treat.* 2016;48(1):266–72.
33. Li H, Wu X, Cheng X. Advances in diagnosis and treatment of metastatic cervical cancer. *J Gynecol Oncol.* 2016;27(4):e43.
34. Bourgioti C, Chatoupis K, Mouloupoulos LA. Current imaging strategies for the evaluation of uterine cervical cancer. *World J Radiol.* 2016;8(4):342.
35. Roh HJ, Kim K Bin, Lee JH, Kim HJ, Kwon YS, Lee SH. Early Cervical Cancer: Predictive Relevance of Preoperative 3-Tesla Multiparametric Magnetic Resonance Imaging. *Int J Surg Oncol.* 2018;2018:1–14.
36. Pannu H, Corl F, Fishman E. CT Evaluation of Cervical Cancer: Spectrum of Disease. *RadioGraphics.* 2015;21(5):1155–68.
37. Prasad T V., Thulker S, Hari S, Sharma DN, Kumar S. Role of computed tomography (CT) scan in staging of cervical carcinoma. *Indian J Med Res.* 2014;139(MAY):714–9.
38. Mirpour S, Mhlanga JC, Logeswaran P, Russo G, Mercier G, Subramaniam RM. The role of PET/CT in the management of cervical cancer. *Am J Roentgenol.* 2013;201(2).
39. Caresia-Arótzgui AP, Delgado-Bolton RC, Alvarez-Ruiz S, del Puig Cózar-Santiago M, Orcajo-Rincon J, de Arcocha-Torres M, et al. 18F-FDG PET/CT in locally advanced cervical cancer: A review. *Rev Esp Med Nucl Imagen Mol.* 2019;38(1):59–68.
40. Fleming S, Cooper RA, Swift SE, Thygesen HH, Chowdhury FU, Scarsbrook AF, et al. Clinical impact of FDG PET-CT on the management of patients with locally advanced cervical carcinoma. *Clin Radiol.* 2014;69(12):1235–43.
41. Egawa N, Egawa K, Griffin H, Doorbar J. Human papillomaviruses; Epithelial tropisms, and the development of neoplasia. *Viruses.* 2015;7(7):3863–90.
42. Nam K. Colposcopy at a turning point. *Obstet Gynecol Sci.* 2018;61(1):1–6.
43. Wentzensen N, Walker JL, Gold MA, Smith KM, Zuna RE, Mathews C, et al. Multiple biopsies and detection of cervical cancer precursors at colposcopy. *J Clin Oncol.* 2015;33(1):83–9.
44. Marth C, Landoni F, Mahner S, McCormack M, Gonzalez-Martin A, Colombo N. Cervical cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol.* 2017;28(Supplement 4):iv72–83.
45. Petry KU, Horn J, Luyten A, Mikolajczyk RT. Punch biopsies shorten time to clearance of high-risk human papillomavirus infections of the uterine cervix. *BMC Cancer.* 2018;18(1):1–7.

46. Alcázar JL, Arribas S, Mínguez JA, Jurado M. The Role of Ultrasound in the Assessment of Uterine Cervical Cancer. *J Obstet Gynecol India*. 2014;64(5):311–6.
47. Dappa E, Elger T, Hasenburger A, Düber C, Battista MJ, Hötker AM. The value of advanced MRI techniques in the assessment of cervical cancer: a review. *Insights Imaging*. 2017;8(5):471–81.
48. Grigsby PW. The prognostic value of PET and PET/CT in cervical cancer. *Cancer Imaging*. 2008;8(1):146–55.
49. Xu X, Li Z, Qiu X, Wei Z. Diagnosis performance of positron emission tomography-computed tomography among cervical cancer patients. *J Xray Sci Technol*. 2016;24(4):531–6.
50. Jung W, Park KR, Lee KJ, Kim K, Lee J, Jeong S, et al. Value of imaging study in predicting pelvic lymph node metastases of uterine cervical cancer. *Radiat Oncol J*. 2017;35(4):340–8.
51. Chen CC, Wang L, Lin JC, Jan JS. The prognostic factors for locally advanced cervical cancer patients treated by intensity-modulated radiation therapy with concurrent chemotherapy. *J Formos Med Assoc*. 2015;114(3):231–7.
52. Liu B, Gao S, Li S. A comprehensive comparison of CT, MRI, positron emission tomography or positron emission tomography/CT, and diffusion weighted imaging-MRI for detecting the lymph nodes metastases in patients with cervical cancer: A meta-analysis based on 67 studies. *Gynecol Obstet Invest*. 2017;82(3):209–22.
53. Ruan J, Zhang Y, Ren H. Meta-analysis of PET/CT detect lymph nodes metastases of cervical cancer. *Open Med*. 2018;13(1):436–42.
54. Poultzidi A, Dimopoulos Y, He TF, Chavakis T, Saloustros E, Lee PP, et al. Lymph Node Cellular Dynamics in Cancer and HIV: What Can We Learn for the Follicular CD4 (Tfh) Cells? *Front Immunol*. 2018;9(September):2233.
55. Liu Y. Postoperative reactive lymphadenitis: A potential cause of false-positive FDG PET/CT. *World J Radiol*. 2014;6(12):890.
56. Li S, Zheng Q, Ma Y, Wang Y, Feng Y, Zhao B, et al. Implications of False Negative and False Positive Diagnosis in Lymph Node Staging of NSCLC by Means of 18F-FDG PET/CT. *PLoS One*. 2013;8(10):1–7.
57. Kusunoki S, Huang KG, Magno A, Lee CL. Laparoscopic technique of para-aortic lymph node dissection: A comparison of the different approaches to trans- versus extraperitoneal para-aortic lymphadenectomy. *Gynecol Minim Invasive Ther*. 2017;6(2):51–7.
58. Gucer F, Misirlioglu S, Ceydeli N, Taskiran C. Robot-assisted laparoscopic transperitoneal infrarenal lymphadenectomy in patients with locally advanced cervical cancer by single docking: Do we need a backup procedure? *J Robot Surg*. 2018;12(1):49–58.
59. Patel K, Foster NR, Kumar A, Grudem M, Longenbach S, Bakkum-Gamez J, et al. Hydronephrosis in patients with cervical cancer: an assessment of morbidity and survival. *Support Care Cancer*. 2015;23(5):1303–9.
60. Vanderpuye V. Renal sonography in the diagnosis of renal obstruction or hydronephrosis in patients with cervical cancer. *J Clin Ultrasound*. 2002;30(7):424–7.
61. Sun R, Koubaa I, Limkin EJ, Dumas I, Bentivegna E, Castanon E, et al. Locally advanced cervical cancer with bladder invasion: Clinical outcomes and predictive factors for vesicovaginal fistulae. *Oncotarget*. 2018;9(10):9299–310.
62. Jeong BK, Huh SJ, Choi DH, Park W, Oh D, Kim T, et al. Indications for endoscopy according to the revised FIGO staging for cervical cancer after MRI and CT scanning. *J Gynecol Oncol*. 2012;23(2):80–5.
63. Fader AN. Surgery in Cervical Cancer. *NEJM*. 2018;379:1955–7.
64. Sun W, Wang T, Shi F, Wang J, Wang J, Hui B, et al. Randomized phase III trial of radiotherapy or chemoradiotherapy with topotecan and cisplatin in intermediate-risk cervical cancer patients after radical hysterectomy. *BMC Cancer*. 2015;15(353):1–7.
65. Asano H, Todo Y, Watari H. Adjuvant chemotherapy for early-stage cervical cancer. *Chinese J Cancer Res*. 2016;28(2):228–34.
66. Hata M, Koike I, Miyagi E, Numazaki R, Asai-Sato M, Kaizu H, et al. Radiation therapy for stage IVA uterine cervical cancer: Treatment outcomes including prognostic factors and risk of vesicovaginal and rectovaginal fistulas. *Oncotarget*. 2017;8(68):112855–66.
67. Vordermark D. Radiotherapy of Cervical Cancer. *Oncol Res Treat*. 2016;39(9):516–20.

68. Sehna B, Kmoníčková E, Sláma J, Tomanová V, Zikán M. Current FIGO Staging for Carcinoma of the Cervix Uteri and Treatment of Particular Stages. *Klin Onkol.* 2019;32(3):224–31.
69. Lim MC, Lee M, Shim SH, Nam EJ, Lee JY, Kim HJ, et al. Practice guidelines for management of cervical cancer in Korea: a Korean Society of Gynecologic Oncology Consensus Statement. *J Gynecol Oncol.* 2017;28(3):e22.
70. Chuang LT, Feldman S, Nakisige C, Temin S, Berrek JS. Management and care of women with invasive cervical cancer: ASCO resource-stratified clinical practice guideline. *J Clin Oncol.* 2016;34(27):3354–5.
71. Akhavan S, Aminimoghaddam S, Rahmani M. Sentinel lymph node in cervical cancer. *Med J Islam Repub Iran.* 2017;31(1):289–92.
72. Diab Y. Sentinel Lymph Nodes Mapping in Cervical Cancer a Comprehensive Review. *Int J Gynecol Cancer.* 2017;27(1):154–8.
73. Banerjee R, Kamrava M. Brachytherapy in the treatment of cervical cancer: A review. *Int J Womens Health.* 2014;6(1):555–64.
74. Kokka F, Bryant A, Brockbank E, Jeyarajah A. Surgical treatment of stage IA2 cervical cancer. *Cochrane Database Syst Rev.* 2014;2014(5).
75. S.P. S, K.R. A. Management of Early Stage Cervical Cancer. *Rev Recent Clin Trials.* 2015;10(4):302–8.
76. Nama V, Angelopoulos G, Twigg J, Murdoch JB, Bailey J, Lawrie TA. Type II or type III radical hysterectomy compared to chemoradiotherapy as a primary intervention for stage IB2 cervical cancer. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018;2018(10).
77. Minig L, Patrono MG, Romero N, Moreno JFR, Garcia-Donas J. Different strategies of treatment for uterine cervical carcinoma stage IB2-IIB. *World J Clin Oncol.* 2014;5(2):86–92.
78. Sturdza A, Pötter R, Fokdal LU, Haie-Meder C, Tan LT, Mazon R, et al. Image guided brachytherapy in locally advanced cervical cancer: Improved pelvic control and survival in RetroEMBRACE, a multicenter cohort study. *Radiother Oncol.* 2016;120(3):428–33.
79. Shim SH, Kim SN, Chae SH, Kim JE, Lee SJ. Impact of adjuvant hysterectomy on prognosis in patients with locally advanced cervical cancer treated with concurrent chemoradiotherapy: A meta-analysis. *J Gynecol Oncol.* 2018;29(2):1–18.
80. Pervin S, Ruma FI, Rahman K, Ferdous J, Ara R, Syed MMA, et al. Adjuvant hysterectomy in patients with residual disease after radiation for locally advanced cervical cancer: A prospective longitudinal study. *J Glob Oncol.* 2019;2019(5):1–7.
81. Mahmoud O, Kilic S, Khan AJ, Beriwal S, Small W. External beam techniques to boost cervical cancer when brachytherapy is not an option-Theories and applications. *Ann Transl Med.* 2017;5(10):207.
82. Sethi RA, Jozsef G, Grew D, Marciscano A, Pennell R, Babcock M, et al. Is there a role for an external beam boost in cervical cancer radiotherapy? *Front Oncol.* 2013;3 JAN(January):1–6.
83. Tangjitgamol S, Katanyoo K, Laopaiboon M, Lumbiganon P, Manusirivithaya S, Supawattanabodee B. Adjuvant chemotherapy after concurrent chemoradiation for locally advanced cervical cancer (Review). *Cochrane Database Syst Rev.* 2014;2014(12).
84. Rema P, Mathew AP, Suchetha S, Ahmed I. Salvage Surgery for Cervical Cancer Recurrences. *Indian J Surg Oncol.* 2017;8(2):146–9.
85. Bonanthaya R, Lakshmaiah K, Babu S, Lokanatha D. Palliative chemotherapy in recurrent carcinoma cervix: experience from a regional cancer centre in southern India. *South African J Gynaecol Oncol.* 2016;8(1):14–7.
86. Scatchard K, Forrest JL, Flubacher M, Cornes P, Williams C. Chemotherapy for metastatic and recurrent cervical cancer. *Cochrane Database Syst Rev.* 2012;2012(10).
87. Hata M, Omura M, Miyagi E, Koike I, Numazaki R, Asai-Sato M, et al. The Role of Radiation Therapy for Stage IVB Uterine Cervical Cancer. *Int J Radiat Oncol.* 2011;81(2):S459.
88. Mishra SK, Laskar S, Muckaden MA, Mohindra P, Shrivastava SK, Dinshaw KA. Monthly palliative pelvic radiotherapy in advanced carcinoma of uterine cervix. *J Cancer Res Ther.* 2005;1(4):208–12.
89. Koh WJ, Abu-Rustum NR, Bean S, Bradley K, Campos SM, Cho KR, et al. Cervical cancer, version 3.2019. *JNCCN J Natl Compr Cancer Netw.* 2019;17(1):64–84.

90. Morris M, Eifel PJ, Lu J, Grigsby PW, Levenback C, Stevens RE, et al. Pelvic Radiation with Concurrent Chemotherapy Compared with Pelvic and Para-Aortic Radiation for High-Risk Cervical Cancer. *N Engl J Med*. 1999;340(15):1137–43.
91. Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, Thigpen T, Depre G, Mainman M, et al. CONCURRENT CISPLATIN-BASED RADIOTHERAPY AND CHEMOTHERAPY FOR LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER. *N Engl J Med*. 1999;340(15):1144–53.
92. Whitney CW, Sause W, Bundy BN, Malfetano JH, Hannigan E V., Fowler WC, et al. Randomized comparison of fluorouracil plus cisplatin versus hydroxyurea as an adjunct to radiation therapy in stage IIB-IVA carcinoma of the cervix with negative para-aortic lymph nodes: A Gynecologic Oncology Group and Southwest Oncology Group Study. *J Clin Oncol*. 1999;17(5):1339–48.
93. Tewari KS, Sill MW, Long HJ, Penson RT, Huang H, Ramondetta LM, et al. Improved Survival with Bevacizumab in Advanced Cervical Cancer. *N Engl J Med*. 2014;370(8):734–43.
94. Kitagawa R, Katsumata N, Shibata T, Kamura T, Kasamatsu T, Nakanishi T, et al. Paclitaxel plus carboplatin versus paclitaxel plus cisplatin in metastatic or recurrent cervical cancer: The open-label randomized phase III trial JCOG0505. *J Clin Oncol*. 2015;33(19):2129–35.
95. Baskar R, Lee KA, Yeo R, Yeoh KW. Cancer and radiation therapy: Current advances and future directions. *Int J Med Sci*. 2012;9(3):193–9.
96. Mayadev J, Viswanathan A, Liu Y, Li CS, Albuquerque K, Damato AL, et al. American Brachytherapy Task Group Report: A pooled analysis of clinical outcomes for high-dose-rate brachytherapy for cervical cancer. *Brachytherapy*. 2017;16(1):22–43.
97. Girinsky T, Rey A, Bi T, Roche A, Haie C, Gerbaulet A, et al. OVERALL TREATMENT TIME IN ADVANCED CERVICAL CARCINOMAS: A CRITICAL PARAMETER IN TREATMENT OUTCOME. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 1993;27(August):1051–6.
98. Yin L, Lu S, Zhu J, Zhang W, Ke G. Ovarian transposition before radiotherapy in cervical cancer patients: Functional outcome and the adequate dose constraint. *Radiat Oncol*. 2019;14(1):1–7.
99. Lin Y, Chen K, Lu Z, Zhao L, Tao Y, Ouyang Y, et al. Intensity-modulated radiation therapy for definitive treatment of cervical cancer: A meta-analysis. *Radiat Oncol*. 2018;13(1):1–8.
100. Salani R, Khanna N, Frimer M, Bristow RE, Chen L may. An update on post-treatment surveillance and diagnosis of recurrence in women with gynecologic malignancies: Society of Gynecologic Oncology (SGO) recommendations. *Gynecol Oncol*. 2017;146(1):3–10.
101. Chu Y, Zheng A, Wang F, Lin W, Yang X, Han L, et al. Diagnostic value of 18F-FDG-PET or PET-CT in recurrent cervical cancer: A systematic review and meta-analysis. *Nucl Med Commun*. 2014;35(2):144–50.
102. Murtaugh CM, Spillman BC, Wang X. Lifetime risk and duration of chronic disease and disability. *J Aging Health*. 2011;23(3):554–77.
103. Rozhok AI, DeGregori J. The Evolution of Lifespan and Age-Dependent Cancer Risk. *Trends in Cancer*. 2016;2(10):552–60.
104. Wensink MJ. Size, longevity and cancer: Age structure. *Proc R Soc B Biol Sci*. 2016;283(1838).
105. Al-Mahrezi A, Al-Mandhari Z. Palliative care: Time for action. *Oman Med J*. 2016;31(3):161–3.
106. Rojas MA, García-Vivar C. The transition of palliative care from the hospital to the home: A narrative review of experiences of patients and family caretakers. *Investig y Educ en Enferm*. 2015;33(3):482–91.
107. Kristjanson LJ, Aoun S. Palliative care for families: Remembering the hidden patients. *Can J Psychiatry*. 2004;49(6):359–65.
108. Heins M, Hofstede J, Rijken M, Korevaar J, Donker G, Francke A. Palliative care for patients with cancer: Do patients receive the care they consider important? A survey study. *BMC Palliat Care*. 2018;17(1):1–7.
109. Stjernswärd J, Foley KM, Ferris FD. The Public Health Strategy for Palliative Care. *J Pain Symptom Manage*. 2007;33(5):486–93.
110. Futagami M, Yokoyama Y, Sato T, Hirota K, Shimada M, Miyagi E, et al. Palliative care for patients with gynecologic cancer in Japan: A Japan society of gynecologic palliative medicine (JSGPM) survey. *Asian Pacific J Cancer Prev*. 2016;17(10):4637–42.

111. Onyeka TC. Psychosocial issues in palliative care: A review of five cases. *Indian J Palliat Care*. 2010;16(3):123–8.
112. Almada AL, Casquinha P, Cotovio V, Dos Santos MJH, Caixeiro A. The potential role of psychosocial rehabilitation palliative care. *J R Coll Physicians Edinb*. 2018;48(4):311–7.
113. Allende Pérez S, Flores Chávez P, Castañeda de la Lanza C. Cuidados paliativos domiciliarios en pacientes con cáncer cervicouterino en etapas avanzadas. *Rev Inst Nac Cancerol*. 2000;46(1):10–6.
114. Schuster M, Bayer O, Heid F, Laufenberg-Feldmann R. Opioid rotation in cancer pain treatment - A systematic review. *Dtsch Arztebl Int*. 2018;115(9):135–42.
115. Treillet E, Laurent S, Hadjiat Y. Practical management of opioid rotation and equianalgesia. *J Pain Res*. 2018;11:2587–601.
116. Mercadante S. The use of anti-inflammatory drugs in cancer pain. *Cancer Treat Rev*. 2001;27(1):51–61.
117. Ali A, Arif AW, Bhan C, Kumar D, Malik MB, Sayyed Z, et al. Managing Chronic Pain in the Elderly: An Overview of the Recent Therapeutic Advancements. *Cureus*. 2018;10(9).
118. Moore RA, Chi CC, Wiffen PJ, Derry S, Rice ASC. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs for neuropathic pain. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;2017(6).
119. Sierko E, Hempel D, Zuzda K, Wojtukiewicz M. Personalized radiation therapy in cancer pain management. *Cancers (Basel)*. 2019;11(3):1–23.
120. Eleje GU, Eke AC, Igberase GO, Igwegbe AO, Eleje LI. Palliative interventions for controlling vaginal bleeding in advanced cervical cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;2019(3).
121. Barbera L, Elit L, Krzyzanowska M, Saskin R, Bierman AS. End of life care for women with gynecologic cancers. *Gynecol Oncol*. 2010;118(2):196–201.
122. Katke RD. Palliative Care of the Patient with Advanced, Recurrent and Metastatic Cervical Cancer: An Institutional Study. *Open Access J Gynecol*. 2018;3(2):1–6.
123. Canga A, Vivar CG, Naval C. Dependencia y familia cuidadora: Reflexiones para un abordaje familiar. *An Sist Sanit Navar*. 2011;34(3):463–9.
124. Pitman A, Suleman S, Hyde N, Hodgkiss A. Depression and anxiety in patients with cancer. *BMJ*. 2018;361(April):1–6.
125. Hong JS, Tian J. Prevalence of anxiety and depression and their risk factors in Chinese cancer patients. *Support Care Cancer*. 2014;22(2):453–9.
126. Tunks ER, Crook J, Weir R. Epidemiology of chronic pain with psychological comorbidity: Prevalence, risk, course, and prognosis. *Can J Psychiatry*. 2008;53(4):224–34.
127. Hoffelt C, Zwack A. Assessment and management of chronic pain in patients with depression and anxiety. *Ment Heal Clin*. 2014;4(3):146–52.
128. Sheng J, Liu S, Wang Y, Cui R, Zhang X. The Link between Depression and Chronic Pain: Neural Mechanisms in the Brain. *Neural Plast*. 2017;2017.
129. Li M, Kennedy EB, Byrne N, Gérin-Lajoie C, Katz MR, Keshavarz H, et al. Management of depression in patients with cancer: A clinical practice guideline. *J Oncol Pract*. 2016;12(8):747–56.
130. Espinoza MA. Evaluación Económica para la toma de decisiones sobre cobertura en salud: ¿qué debe saber el profesional de la salud? *Rev Chil Cardiol*. 2017;36(2):144–53.
131. García-Altés A, Navas E, Soriano MJ. Evaluación económica de intervenciones de salud pública. *Gac Sanit*. 2011;25(SUPPL. 1):25–31.
132. Mejia Mejia A, Viscaya MM. Evaluación económica para la toma de decisiones en salud en Colombia. *Monit estratégico*. 2014;(5):70–5.
133. Pisu M, Henrikson NB, Banegas MP, Yabroff KR. Costs of cancer along the care continuum: What we can expect based on recent literature. *Cancer*. 2018;124(21):4181–91.
134. Auguste P, Barton P, Meads C, Davenport C, Małysiak S, Kowalska M, et al. Evaluating PET-CT in routine surveillance and follow-up after treatment for cervical cancer: A cost-effectiveness analysis. *BJOG An Int J Obstet Gynaecol*. 2014;121(4):464–76.

135. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Directriz para el fortalecimiento de los programas nacionales de guías informadas por la evidencia [Internet]. Washington DC; 2018 [cited 2020 Jul 23]. Available from: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49145/9789275320167_spa.pdf
136. Grimshaw J, Russell I. Effect of clinical guidelines on medical practice : review of rigorous evaluations. *Lancet*. 1993;342:1317–22.
137. Smith TJ, Hillner BE. Ensuring quality cancer care by the use of clinical practice guidelines and critical pathways. *J Clin Oncol*. 2001;19(11):2886–97.
138. Pierson DJ. Translating evidence into practice. *Respir Care*. 2009;54(10):1386–401.
139. Heins MJ, De Jong JD, Spronk I, Ho VKY, Brink M, Korevaar JC. Adherence to cancer treatment guidelines: Influence of general and cancer-specific guideline characteristics. *Eur J Public Health*. 2017;27(4):616–20.
140. Grol R, Grimshaw J. From best evidence to best practice: Effective implementation of change in patients' care. *Lancet*. 2003;362(9391):1225–30.
141. Congreso de Colombia. LEY 1122 DE 2007. "Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" [Internet]. Bogotá DC; 2007 [cited 2020 Nov 3]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf>
142. Taylor A. Five-Step Approach to Stakeholder Engagement. *Bus Soc Responsib* [Internet]. 2019;41. Available from: <https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/stakeholder-engagement-five-step-approach-toolkit>
143. Ministerio de Salud y Protección Social. Manual de implementación de guías de práctica clínica basadas en evidencia, en instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia [Internet]. Bogotá DC; 2014 [cited 2020 Jul 23]. Available from: http://gpc.minsalud.gov.co/recursos/Documentos compartidos/Manual_de_implementacion.pdf
144. Porter M, Lee T. The Strategy that will fix health-care. *Harv Bus Rev*. 2014;(October 2013):1–19.
145. Organización Panamericana de la Salud. Cuidados innovadores para las condiciones crónicas. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 2013. p. 105.

**GUÍA PARA LA ATENCIÓN, EL MANEJO
Y EL CUIDADO DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO
DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO INVASIVO
Cali - Colombia**



CALI - COLOMBIA